



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Rodrigo Antonio Devellis

Diagnóstico do risco: o paciente parcial e a expansão do acesso à PrEP no Brasil

FLORIANÓPOLIS

2026

Rodrigo Antonio Devellis

**Diagnóstico do risco: o paciente parcial e a expansão do acesso à PrEP
no Brasi**

Projeto de Trabalho de Conclusão de
licenciatura em Ciências Sociais do Centro
de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Santa Catarina
como requisito para a obtenção do título de
bacharelado em Ciências Sociais

Orientadora: Márcia da Silva Mazon

Devellis, Rodrigo Antonio

Diagnóstico do risco: o paciente parcial e a expansão do acesso à PrEP entre adolescentes no Brasil / Rodrigo Antonio Devellis ; orientadora, Márcia da Silva Mazon, 2026.

[83] p.

Trabalho de Conclusão de Curso (licenciatura) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Licenciatura em Ciências Sociais, Florianópolis, 2026.

Inclui referências.

1. PrEP (Profilaxia Pré-Exposição). 2. HIV - Prevenção. 3. Adolescentes - Saúde. 4. Biopolítica. 5. Medicalização. I. Mazon, Márcia da Silva. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Licenciatura em Ciências Sociais. III. Título.

RESUMO

Este estudo analisa as diretrizes que estendem a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) a adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil, tal como codificadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de 2025. Mais do que avaliar o acerto ou o erro da medida, a pesquisa interroga as suas condições de possibilidade: descreve o modo pelo qual o protocolo torna o jovem inteligível e governável, constituindo-o, no gesto mesmo com que o protege, como sujeito sexualmente ativo, autônomo, compreendente e acompanhado. Trata-se de uma leitura de inspiração genealógica, que recusa tanto a celebração quanto a denúncia da política e que, na chave de Lindsay Prior, lê o documento como dispositivo: não um instrumento neutro de prevenção, mas uma peça que produz o sujeito sobre o qual incide. As noções de dispositivo, biopolítica e governamentalidade, em Foucault, situam a profilaxia numa racionalidade que conduz condutas; a medicalização do risco e a figura do paciente parcial, que Conrad recupera de Greaves, descrevem o usuário que, sem se perceber doente, é classificado como exposto e convocado a gerir, sob medicação contínua e vigilância clínica, a própria probabilidade de adoecer; a política vital e a cidadania biológica, em Rose, inscrevem essa vida numa economia e, ao mesmo tempo, deixam ver a possibilidade de reivindicá-la como direito. A própria adolescência sobre a qual o protocolo incide comparece, então, não como dado natural, mas como categoria historicamente construída. Conclui-se que cuidado e controle não se opõem: produzem-se juntos, e a PrEP, antes de operar como técnica preventiva, supõe um sujeito de risco que precisou ser constituído; são as condições e os efeitos dessa constituição que o trabalho se propõe a descrever.

Palavras-chave: PrEP; adolescência; HIV/aids; PCDT; medicalização do risco; dispositivo; biopolítica; governamentalidade; paciente parcial; cidadania biológica.

ABSTRACT

This study analyzes the guidelines that extend HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) to adolescents aged 15 to 19 in Brazil, as codified in the 2025 Clinical Protocol and Therapeutic Guidelines. Rather than assessing whether the measure is right or wrong, the research examines its conditions of possibility: it describes the way in which the protocol renders the young person intelligible and governable, constituting that adolescent, in the very gesture by which it offers protection, as sexually active, autonomous, comprehending, and monitored. This is a genealogically inspired reading, one that refuses both the celebration and the denunciation of the policy and that, following Lindsay Prior, reads the document as an apparatus (*dispositif*): not a neutral instrument of prevention, but a device that produces the very subject upon which it bears. The notions of apparatus, biopolitics, and governmentality, in Foucault, situate prophylaxis within a rationality that conducts conduct; the medicalization of risk and the figure of the partial patient, which Conrad takes from Greaves, describe the user who, without perceiving themselves as ill, is classified as exposed and called upon to manage, under continuous medication and clinical surveillance, their own probability of falling ill; vital politics and biological citizenship, in Rose, inscribe this life within an economy while also disclosing the possibility of claiming it as a right. Adolescence itself, upon which the protocol bears, thus appears not as a natural given but as a historically constructed category. It is concluded that care and control are not opposed: they are produced together, and PrEP, before operating as a preventive technique, presupposes a subject of risk that had to be constituted. It is the conditions and effects of that constitution that this study sets out to describe.

Keywords: PrEP; adolescence; HIV/AIDS; clinical protocol; medicalization of risk; *dispositif*; biopolitics; governmentality; partial patient; biological citizenship.

INTRODUÇÃO.....	8
PERGUNTA DE PESQUISA.....	9
OBJETIVO GERAL.....	10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
JUSTIFICATIVA.....	10
METODOLOGIA.....	11
QUADRO TEÓRICO MÍNIMO.....	12
1. DISPOSITIVO E PCDT.....	13
1.2. SEXUALIDADE LIVRE MAS PRODUZIDA.....	17
1.3. DEFINIÇÃO.....	18
1.4. A PrEP PARA ADOLESCENTES: A AUTONOMIA COMO INSCRIÇÃO NO DISPOSITIVO.....	20
1.5. SÍNTESE.....	23
2. DISPOSITIVO DA AIDS.....	24
2.1. ENTRE OS JORNAIS FRANCESES.....	27
2.2. NA ONDA DA MODA.....	30
2.3. A SOCIEDADE.....	31
2.4. SIDA nização.....	34
3. PESSOAS JOVENS.....	37
3.1. BIOLÓGICOS E CULTURAIS.....	40
3.2. CONSTRUÇÃO HISTÓRICA.....	43
3.3. APENAS UMA PALAVRAS.....	45
4. PCDT, O DOCUMENTO.....	48
4.1. SEXUALIDADE, VIDA E POPULAÇÃO.....	48
4.2. SEGURANÇA, CIRCULAÇÃO E ELEGIBILIDADE.....	51
4.3. VERDADE, EVIDÊNCIA E DECISÃO.....	54
4.4. SUJEITO ADERENTE E LIMITES DO DISPOSITIVO.....	59
5. O MEDICAMENTO.....	62
5.1. AZT.....	62
5.2. MEDICALIZAÇÃO.....	67
5.3. BIOCIDADANIA.....	71
CONCLUSÃO.....	72
REFERÊNCIAS.....	77

INTRODUÇÃO

A profilaxia pré-exposição ao HIV, conhecida pela sigla PrEP, consiste no uso de medicamento antirretroviral por pessoas que não vivem com o vírus, com a finalidade de reduzir a probabilidade de infecção. No Brasil, ela integra as estratégias de prevenção combinada disponíveis no Sistema Único de Saúde, ao lado da testagem regular, da profilaxia pós-exposição, do uso de preservativos e do tratamento das pessoas que vivem com HIV (BRASIL, 2025). Diferentemente do tratamento, dirigido a quem já adoeceu, a PrEP opera antes do contágio: inscreve-se numa temporalidade voltada ao futuro, em que se medica no presente um corpo saudável em nome de um adoecimento que se quer impedir.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, em sua versão de 2025, consolida uma inflexão relevante nesse arranjo. O documento abre sua justificativa por um dado epidemiológico: os novos casos de aids, lê-se, concentram-se majoritariamente na população jovem, de 15 a 24 anos (BRASIL, 2025, p. 11). A esse dado corresponde uma ampliação do alcance da profilaxia. Suprimida a indicação restrita às chamadas populações-chave, o protocolo passa a admitir a PrEP para todas as pessoas a partir

dos quinze anos, com peso igual ou superior a 35 kg, em contextos de vulnerabilidade para a aquisição do HIV (BRASIL, 2025, p. 12). O adolescente, antes não contemplado de modo específico, é assim incorporado como sujeito elegível.

A essa incorporação soma-se um deslocamento de ordem jurídica. O protocolo dispõe que a pessoa maior de quinze anos pode iniciar a profilaxia sem a anuência de pais ou responsáveis, sob reserva de sigilo, ressalvada a situação de risco de vida (BRASIL, 2025, p. 21). O acesso passa a depender da relação entre o adolescente e o serviço de saúde, sem a mediação da família. Esse arranjo não é arbitrário: apoia-se no Estatuto da Criança e do Adolescente e no dever de confidencialidade inscrito no Código de Ética Médica, que o próprio documento invoca (BRASIL, 2025, p. 21).

Num país marcado por desigualdades intensas e por acesso desigual à saúde, alcançar adolescentes que com frequência não encontram apoio na família, na escola ou nas instituições corresponde a uma necessidade concreta, e a importância pública da medida não está em disputa. É, contudo, quando uma política se apresenta dessa forma, como cuidado, como ampliação de direito, como resposta a um risco previamente dado, que parece útil suspender a leitura imediata. Pois o protocolo não se limita a identificar um grupo já existente para protegê-lo: ao defini-lo, articula um saber biomédico, aciona normas jurídicas, dispõe critérios de elegibilidade e fluxos de acompanhamento e delineia certa figura do adolescente: sexualmente ativo, autônomo, apto a compreender e a aderir ao monitoramento. Esse adolescente não antecede inteiramente o documento que lhe dá nome; é, em parte, efeito dele.

PERGUNTA DE PESQUISA

É desse problema que decorre a investigação. Concebê-la em termos de análise — e não de causas, de efeitos ou dos méritos da medida — já é uma decisão de método: supõe que a indicação da profilaxia ao adolescente não se explica apenas por uma necessidade epidemiológica que a precederia, mas se torna possível sobre um terreno que cumpre reconstituir.

De que modo o protocolo torna o adolescente inteligível e governável — sexualmente ativo, autônomo, apto a compreender e a aderir ao acompanhamento — ao defini-lo como elegível?

A investigação volta-se, assim, à análise das diretrizes que indicam a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao adolescente de 15 a 19 anos no Brasil.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral traduz esse percurso analítico. Trata-se de articular um conjunto de categorias a um caso determinado, o protocolo de 2025, lido não como ilustração das teorias, mas como o lugar em que elas são postas a operar.

Analisar, a partir de revisão teórica e bibliográfica, as condições sociais, históricas e teóricas que tornam possível a expansão do acesso à PrEP entre adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil, articulando as categorias de dispositivo, biopolítica, governamentalidade, medicalização e cidadania biológica ao caso codificado no PCDT da PrEP (BRASIL, 2025).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Esse objetivo se desdobra em dois movimentos, que organizam também a divisão do trabalho: o primeiro situa a PrEP na história da resposta brasileira à aids; o segundo toma o adolescente como categoria construída e examina como o protocolo a opera.

- Examinar a PrEP como tecnologia inscrita no dispositivo da aids, identificando os deslocamentos internos que sua incorporação produz na configuração brasileira da prevenção, mediante a articulação entre o referencial foucaultiano (dispositivo, biopolítica, governamentalidade), a categoria de medicalização do risco (Conrad) e a categoria de cidadania biológica (Rose).
- Examinar o adolescente como categoria historicamente construída e como segmento populacional alvo da expansão da PrEP, reconstituindo a sociogênese da categoria e a forma como ela é operacionalizada no PCDT por meio dos critérios de elegibilidade, dos arranjos jurídicos que dispensam autorização parental e da articulação entre marcadores etários, comportamentais e epidemiológicos.

JUSTIFICATIVA

A inclusão do adolescente como sujeito elegível à PrEP marca uma inflexão na política brasileira de prevenção ao HIV, e é essa inflexão que justifica o estudo. Ao fixar os quinze

anos como limiar de acesso, ao dispensar a autorização parental e ao garantir sigilo na relação com o serviço de saúde, o PCDT de 2025 não apenas estende uma tecnologia já existente a uma faixa etária antes não contemplada: ele incorpora o jovem à política pública como sujeito que acessa a profilaxia por iniciativa própria, sem a mediação da família.

O que parece pouco examinado é o modo como essa entrada na política pública se organiza: por meio de quais critérios de elegibilidade, de quais arranjos jurídicos e de qual figura do adolescente, sexualmente ativo, autônomo, apto a compreender e a aderir ao acompanhamento.

Este trabalho se justifica, então, por tomar a inclusão do adolescente na política de PrEP não como dado a celebrar ou a denunciar, mas como objeto a descrever: interessa examinar o que essa incorporação supõe, o que ela produz e quais sujeitos ela convoca ao ampliar o acesso.

METODOLOGIA

Este trabalho se inscreve no registro da pesquisa qualitativa, de natureza teórico-bibliográfica e documental. Não recorre a trabalho de campo, a entrevistas ou a dados primários produzidos pelo pesquisador; seu material são, de um lado, o corpus teórico mobilizado para construir as categorias de análise e, de outro, um documento determinado — o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (BRASIL, 2025) —, tomado como fonte central.

A revisão bibliográfica não cumpre função meramente introdutória. As categorias que organizam a leitura são construídas no próprio percurso pelos autores: o dispositivo, a biopolítica e a governamentalidade a partir de Foucault; a medicalização a partir de Conrad; a cidadania biológica e a política vital a partir de Rose. A reconstituição da adolescência como categoria historicamente produzida apoia-se em um conjunto mais amplo — de Durkheim, Marx e Weber a Hall, Boas, Mead, Ariès e Bourdieu —, e a genealogia do dispositivo da aids articula trabalhos de orientação distinta. À configuração brasileira da resposta à epidemia (Barata, Herzlich e Pierret, Perlongher, De la Dehesa, Pelúcio e Miskolci) soma-se a análise de Steven Epstein sobre a trajetória do AZT, retomada no capítulo dedicado ao medicamento: a constituição contestada da evidência clínica, o ativismo terapêutico que aprende a ler e a disputar os ensaios e a passagem, no tratamento precoce, de um corpo são a paciente (EPSTEIN, 1996). Esses textos não comparecem como ilustração, mas como instâncias em que os conceitos são postos a operar antes de serem aplicados ao protocolo.

A análise do PCDT segue a perspectiva de Lindsay Prior, para quem um documento não é suporte neutro de informação, mas elemento ativo: tem autoria distribuída (author-function), condensa mandatos, hierarquias e procedimentos de validação, e participa da constituição daquilo que parece apenas registrar. Sob essa chave, o protocolo é lido como dispositivo documental — composição heterogênea de mandato jurídico, evidência científica, julgamento técnico e fluxos administrativos. O procedimento é, assim, o de uma leitura analítica e detida do texto, atenta a seus critérios de elegibilidade, a seus arranjos jurídicos, ao vocabulário do risco e da vulnerabilidade e à figura do adolescente que o documento supõe e produz^[^0].

O modo de leitura é de inspiração genealógica. Em vez de avaliar se o protocolo acerta ou erra, ou de medi-lo contra uma norma externa, a análise procura descrever de que maneira ele torna certas realidades inteligíveis e governáveis — como constitui o jovem em superfície de incidência, como desliga a sexualidade do adolescente do circuito da família para religá-la à relação clínica, como produz a autonomia que diz reconhecer. A articulação entre as categorias teóricas e o documento é, portanto, o eixo do método: as primeiras fornecem os procedimentos de leitura; o segundo, a matéria sobre a qual se exercem.

Cabe registrar um limite, que é também uma escolha. A análise se detém no plano da página, isto é, no protocolo como dispositivo escrito. Como observa o próprio Prior, o texto é apenas uma das dimensões da vida social de um documento; seu funcionamento efetivo nos serviços, nas dispensações e nos encontros clínicos escaparia a uma leitura assim circunscrita e exigiria outra estratégia de pesquisa. Reconhecer esse limite delimita o alcance das conclusões: o que o trabalho descreve são os efeitos de subjetivação inscritos no documento, não os seus usos.

QUADRO TEÓRICO MÍNIMO

A análise se apoia em um conjunto delimitado de categorias, mobilizadas menos como sistema fechado do que como instrumentos de leitura postos a operar sobre o protocolo. O eixo é fornecido por Michel Foucault. Do seu vocabulário retêm-se três noções articuladas: a de dispositivo — a rede heterogênea de discursos, leis, normas e práticas que responde a uma urgência histórica e produz os sujeitos sobre os quais incide (FOUCAULT, 1998); a de biopolítica e governamentalidade, que convém não fundir — a biopolítica nomeia a vida das populações, seus índices de natalidade, morbidade e mortalidade, tomada como superfície de intervenção; a governamentalidade, a forma geral dessa racionalidade e as tecnologias por que ela conduz condutas (FOUCAULT, 2008); e a distinção entre o dispositivo da aliança —

centrado na família, no parentesco e na transmissão de nomes e de bens — e o dispositivo da sexualidade — centrado na clínica, no exame e na gestão das condutas corporais —, articulados pela família como permutador, distinção que permite ler a dispensa da autorização parental não como simples remoção de um entrave, mas como deslocamento de um regime de poder a outro: o acesso à profilaxia desprende-se do circuito da aliança e religa-se ao do exame clínico (FOUCAULT, 1999). À biopolítica corresponde a leitura do fundo epidemiológico que constitui o adolescente em objeto de incidência; à governamentalidade, a do protocolo como tecnologia de governo.

A essas noções soma-se a categoria de medicalização, tomada de Peter Conrad. Interessa nela menos a denúncia de uma expansão indevida da medicina do que o deslocamento analítico que propõe: um problema passa a ser definido em termos médicos, e definir é conferir jurisdição (CONRAD, 2006). Importam sobretudo suas extensões — a medicalização do risco, que trata como condição atual aquilo que é apenas probabilidade futura, a figura do paciente parcial, que medica um corpo sem doença, e a individualização dos problemas sociais, que fixa no indivíduo a resposta a uma vulnerabilidade de origem coletiva (CONRAD, 2006, 2007).

Onde Conrad descreve a operação, Nikolas Rose pergunta quem o sujeito se torna ao ser nela inscrito. Dele provêm a política vital, voltada à modulação das capacidades vitais no plano molecular, e a cidadania biológica, em seu duplo momento — o que reconfigura a relação do indivíduo com a própria individualidade somática e o que organiza solidariedades e demandas em torno de estatutos biológicos compartilhados (ROSE, 2007). Por fim, no plano do método, a leitura mobiliza Lindsay Prior e a concepção do documento como elemento ativo — e não suporte neutro de informação (PRIOR, 2003) —, nos termos expostos na seção de metodologia. A reconstituição da adolescência como categoria historicamente produzida mobiliza ainda um conjunto mais amplo, da tradição sociológica clássica a Ariès e Bourdieu, cujo lugar é o capítulo a ela dedicado.

1. DISPOSITIVO E PCDT

Em Michel Foucault, a noção de dispositivo não remete a uma coisa separada, tomada em si, mas a uma configuração de relações. Nela se reúnem discursos, instituições, leis, regras administrativas, enunciados científicos e práticas de cuidado; o ponto decisivo, porém, não

reside em cada elemento isoladamente considerado, e sim no arranjo relacional que se estabelece entre eles. Um dispositivo se constitui em resposta a uma urgência histórica e, nesse processo, mais do que regular, ele produz saberes, organiza condutas e intervém na própria constituição dos sujeitos sobre os quais incidem seus efeitos (FOUCAULT, 1998, p. 244-246). É essa configuração, ao mesmo tempo móvel, heterogênea e estratégica, que orienta a leitura adotada neste capítulo.

Considerado de fora, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição ao HIV pode parecer apenas mais um documento técnico: nele se define quem deve ter acesso à profilaxia, em quais condições e com que tipo de acompanhamento (BRASIL, 2025). Sua importância para a saúde pública é inegável e não está em questão: em um país atravessado por desigualdades profundas e por acessos desiguais aos serviços de saúde, a ampliação da PrEP para adolescentes responde a uma necessidade histórica concreta. Mas é precisamente quando um texto se apresenta como neutro, ou como simples resposta a um risco já dado, que a análise do dispositivo se torna mais necessária. Pois o protocolo não se limita a reconhecer um grupo vulnerável para então protegê-lo. Ao fazê-lo, ele põe em relação um saber biomédico, mobiliza normas jurídicas, organiza circuitos de dispensação e configura uma determinada figura do adolescente, sexualmente ativo, autônomo e acompanhado (BRASIL, 2025, p. 11-12; p. 20-21). O capítulo assume, portanto, uma dupla exigência: reconhecer no PCDT um instrumento legítimo de cuidado e, ao mesmo tempo, interrogar aquilo que ele faz surgir no próprio ato de cuidar, já que a figura do adolescente que o documento nomeia é também, em certa medida, produzida por ele. Como se assinala na justificativa, a análise não se coloca nem sob o signo da denúncia nem sob o da celebração; trata-se, antes, de examinar, nessa passagem entre proteção e produção, de que maneira a autonomia reconhecida ao adolescente pelo protocolo é também a forma pela qual ele é inscrito em uma rede que o observa, o descreve e o acompanha (FOUCAULT, 1998, p. 244-246; FOUCAULT, 1999, p. 88-100). É esse deslocamento que conduz as páginas que seguem.

1.1. SOBRE A VIGILÂNCIA: SUAVIZADA E SOFISTICADA

Convém explicitar em que sentido Vigiar e punir comparece nesta análise. Não como repertório de teses sobre a prisão a serem transpostas ao protocolo, pois a distância entre os dois objetos desautorizaria, de saída, qualquer transposição, mas como o lugar em que a analítica do dispositivo se deixa ver em exercício, antes mesmo de receber o nome que a

definição posterior lhe fixará. O que o livro oferece é menos um conceito enunciado do que uma operação demonstrada: o modo de ler um campo heterogêneo sem reduzi-lo a um princípio, de medir a distância entre o programa que se escreve e os efeitos que a prática impõe, de reconhecer função inclusive naquilo que o projeto havia rejeitado. É essa operação, e não a cena penal que lhe serve de matéria, o que aqui se retém.

Tomado assim, o livro funciona menos como fonte do que como forma: fornece o procedimento com que, adiante, o PCDT poderá ser lido não como peça isolada, mas como trama. Se há algo que passe de um domínio ao outro, não é o conteúdo carcerário; é a maneira de pôr o dispositivo a funcionar diante de um documento determinado.

A mitigação das penas se lê, de início, como a exposição de um programa reformador. Quem o percorre, porém, logo se depara com elementos que não pertencem à mesma ordem. Uma proposição filosófica, a de que as instituições políticas “se fundamentam na natureza”, figura ao lado de regulamentos como o horário da penitenciária na Filadélfia; discursos de juristas, ao lado de projetos arquitetônicos como a cidade punitiva (Foucault, 1987, pp. 126, 132-133, 143-144). Nada, à primeira vista, autoriza reuni-los: o que teria o enunciado de um princípio em comum com a planta de um edifício? E, no entanto, ali estão, sem hierarquia entre o dito e o construído. Quando um reformador exige que o legislador seja “um arquiteto hábil”, a própria fronteira entre o enunciado e o edifício deixa de valer: ambos pertencem à mesma trama (Foucault, 1987, p. 126). Resta a pergunta que comanda toda a leitura: se o que mantém juntos elementos tão dispersos não é uma doutrina, o que é, então, essa trama?

Essa rede responde a uma urgência. O suplício, dispendioso e incerto, deixara de servir; tratava-se de instituir uma arte de punir voltada não ao corpo de um culpado, mas ao cálculo de todos os culpados possíveis. Para alcançar esse alvo, a pena age sobre representações por meio de outras representações: ao crime deve ligar-se a ideia de um castigo cuja desvantagem prevista anule a vantagem imaginada do delito, e tal emparelhamento só funciona exposto, na publicidade. Essa mecânica exige um saber: importa “conhecer o princípio das sensações e das simpatias que se produzem no sistema nervoso” (Foucault, 1987, p. 148), pois é do conhecimento das associações que a pena-sinal depende. Mas, sob esse saber público e representacional, já se infiltra um outro, de natureza diversa: na penitenciária na Filadélfia, a administração recolhe o relatório do crime, o resumo do interrogatório e as notas sobre a conduta, para determinar que cuidados destruiriam os velhos hábitos deste condenado, saber individualizante e discreto, voltado não ao culpado virtual, mas a um sujeito singular cujos

hábitos se quer refazer (Foucault, 1987, pp. 145-146). De um modo e de outro, o saber sobre o criminoso não antecede o poder que o pune; nasce com ele e o sustenta.

Resta o elemento que o programa recusa. A prisão é declarada incompatível com toda a técnica da pena-sinal, incapaz de especificar os crimes, sem efeito sobre o público, semelhante a “um médico que, para todas as doenças, tem o mesmo remédio” (Foucault, 1987, p. 136). E, no entanto, em pouco tempo, é ela que ocupa quase todo o campo das punições: o Código de 1810 instaura “o encarceramento sob todas as suas formas” (Foucault, 1987, p. 135). O recusado venceu. O que se impõe na prática não é o que o projeto quis, mas exatamente o que ele rejeitara: a peça descartada não é suprimida, e sim reabsorvida, o fracasso do programa converte-se no seu centro. Mas esse fracasso reabsorvido tem um conteúdo, que as partes finais do livro tornarão explícito: a prisão não reduz o crime, produz reincidência, isola um meio, encadeia carreiras, e é esse efeito, não o que dela se esperava, que o aparato retém e põe a funcionar (Foucault, 1987, pp. 293-299, 307-309, 327). O que o programa contava suprimir converte-se em produção sua: um sujeito que a instituição observa, descreve e classifica, e que é, no mesmo gesto, objeto de um saber e alvo de um poder.

Daí a pergunta com que o capítulo se encerra: como o modelo coercitivo, corporal e secreto pôde substituir o modelo cênico, público e significativo. A pergunta é insolúvel enquanto se leia a punição como realização de um programa; torna-se tratável apenas quando se a lê como decantação contingente de forças heterogêneas, na qual até a peça rejeitada encontra função. O instrumento capaz de responder já está em ato no capítulo, antes de receber um nome, é ele que permite ler a distância entre o projeto que os reformadores escreveram e a prisão que a prática impôs (Foucault, 1987, pp. 150-151).

Esse deslocamento, contudo, só pode manter-se apoiado na concepção de poder que o exemplo penal já deixava entrever. Aqui, poder não designa algo que alguém possua e o faça valer sob a forma da interdição. Designa, antes, uma relação, um exercício, uma pluralidade de forças imanentes ao campo em que opera (FOUCAULT, 1999, p. 88-91). Tomá-lo em sua produtividade impõe, então, outra pergunta: que é que ele produz?

“A Vontade de saber” oferece a isso uma resposta precisa por meio de um caso determinado: o da criança masturbadora. Não está em questão uma criança que desde sempre se masturbaria e sobre a qual o poder viria, depois, impor a proibição. Foi o dispositivo que a

constituiu como sujeito sexual. Fez reconhecer em seu sexo algo ao mesmo tempo natural, valioso e ameaçado; dispôs ao redor dele pais, médicos e pedagogos encarregados de vigiá-lo; e, com isso, abriu um campo de saber que a simples interdição, por si só, nunca produziria (FOUCAULT, 1999, p. 29-36; 99). O próprio interdito também é efeito. Aquilo que precede a norma não é o corpo nu, mas o corpo já tornado legível por técnicas que o investiram.

Por isso, não convém reduzir o poder a uma superestrutura encarregada apenas de dizer não. Ali onde atua, atua produzindo: incita o discurso, multiplica os saberes, intensifica as sensações, fabrica as figuras por meio das quais um corpo torna-se legível e governável (FOUCAULT, 1999, p. 21-35; 45-49). Não envolve a sexualidade a partir de fora. Constitui-a de dentro — e constitui, com ela, os próprios sujeitos que a habitam (FOUCAULT, 1999, p. 93-100).

A figura da criança não se encerra nesse ponto. Quando o protocolo vier a constituir o adolescente como sujeito apto para a autonomia, retomará, em outro registro e com outros instrumentos, aquele gesto inaugural.

1.2. SEXUALIDADE LIVRE MAS PRODUZIDA

Se o poder é produtor, uma desconfiança de método se impõe, a mesma que recusou ler a passagem do suplício à prisão como simples abrandamento (FOUCAULT, 1987, p. 12-20; 150-151). Aquilo que se oferece como alívio, como margem, como liberdade reconquistada sobre uma antiga proibição pode ser menos um fora do dispositivo do que um de seus efeitos mais finos. Afirmar o sexo não é, sem mais, negar o poder: pode ser ainda mover-se conforme o traçado do dispositivo que organiza o que se vive como permissão. Não que a experiência da liberdade seja ilusória, é que ela não está, por ser vivida como libertação, do lado de fora daquilo que a tornou possível. O dispositivo não proíbe o prazer de um lado para liberá-lo de outro. Produz, no mesmo gesto, o prazer e o discurso que o nomeia como conquista (FOUCAULT, 1999, p. 45-49; 100-101).

E produz, no limite, a própria categoria sob a qual tudo isso se deixa pensar. O “sexo”, essa instância que parece estar por baixo de tudo o que somos e que interrogamos para que nos diga quem somos, não é o ponto de partida da sexualidade, mas seu efeito: a unidade fictícia, embora necessária, que permite reunir sob um único nome anatomias, funções, condutas, sensações e prazeres, e fazer dessa reunião a cifra de uma identidade (FOUCAULT, 1999, p.

136-139). Tal produtividade marca a especificidade histórica do dispositivo, e o distingue do registro que o antecede e com ele coexiste. O dispositivo de aliança opera por regras fixas de lícito e ilícito, voltado não a produzir mas a reproduzir: reproduzir a trama do parentesco, sustentar a lei que a rege, articular a transmissão de bens e de nomes. É nesse registro que a linguagem jurídica encontra sua adequação natural; a lei fala com precisão sobre quem pode casar com quem, sobre guarda, sobre herança, sobre quem autoriza o quê. O dispositivo da sexualidade fala outra língua: não regras fixas mas técnicas móveis e polimorfos; não reprodução mas proliferação, extensão permanente dos domínios de controle sobre o corpo que produz e consome. Os dois dispositivos não se sucedem, coexistem, e a família funcionou historicamente como permutador entre eles: ponto por onde a lei e o jurídico passam ao dispositivo da sexualidade e a economia do prazer retorna ao regime da aliança (FOUCAULT, 1999, p. 100-106). Tudo o que se dissesse sobre a sexualidade do menor passava, historicamente, por esse permutador. É sobre ele que o protocolo vai agir.

1.3. DEFINIÇÃO

Dois domínios, uma mesma analítica. No capítulo penal, o que importou não foi a intenção dos reformadores mas o campo heterogêneo que eles mobilizaram sem dominar, e a peça recusada foi exatamente a que venceu (FOUCAULT, 1987, p. 134-136; 150-151). Em A vontade de saber, o que importou não foi a norma que o poder estabeleceu sobre o sexo mas o sujeito que ele fabricou ao estabelecê-la, e o que se oferece como libertação é ainda movimento dentro do que se pretendia deixar para trás (FOUCAULT, 1999, p. 88-97; 100-106; 136-139). Em ambos os casos, o instrumento analítico não é a lei, nem a instituição, nem o discurso tomado à parte: é a trama que os articula, a urgência que os convoca, os efeitos que se produzem além de qualquer intenção. Esse instrumento operou nos dois capítulos antes de receber um nome. Recebe-o agora.

Em primeiro lugar, o dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo. Reúne discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em suma, o dito e o não dito. O dispositivo não é nenhum desses elementos tomado à parte; é a rede que se estabelece entre eles (FOUCAULT, 1998, p. 244). Aqui o conceito recebe o nome do que o capítulo já vinha mostrando: nem a lei, nem a instituição, nem o saber, mas a trama que os faz sustentar-se e deslocar-se uns em relação aos outros.

Em segundo lugar, o dispositivo é a natureza da relação que se estabelece entre esses elementos heterogêneos. A relação não é fixa: há entre eles um jogo, mudanças de posição, modificações de função. Um mesmo discurso pode mudar de papel conforme a estratégia em que entra, pode reforçar um efeito de poder num arranjo e, deslocado, miná-lo em outro. O dispositivo não é a soma de suas peças; é o sistema móvel das relações entre elas (FOUCAULT, 1998, p. 244).

Em terceiro lugar, e este é o tempo decisivo, o dispositivo é uma formação que, em dado momento histórico, teve por função responder a uma urgência. Tem, portanto, função estratégica dominante (FOUCAULT, 1998, p. 244). Não nasce de um plano nem de uma intenção que o anteceda inteiro: emerge para respondê-la e só depois se ordena, segundo a lógica estratégica dessa resposta. Por isso está sempre inscrito num jogo de poder e sempre ligado a limites de saber que dele nascem e que, por sua vez, o condicionam (FOUCAULT, 1998, p. 246), como o exemplo da criança já deixara ver: o saber sobre o sexo não precede o poder que o convoca, mas nasce com ele e o sustenta. Saber e poder não são, no dispositivo, duas instâncias que se aplicam uma sobre a outra: são estratégias de força que sustentam tipos de saber e por eles são sustentadas (FOUCAULT, 1998, p. 246).

Dessa terceira dimensão Foucault extrai dois movimentos que importam menos à definição do que ao seu uso. O primeiro é a sobredeterminação funcional: cada efeito do dispositivo, querido ou não, entra em ressonância ou em contradição com os demais, e exige reajuste, recomposição, novo arranjo. O segundo é o preenchimento estratégico: um dispositivo nascido para responder a certa urgência produz efeitos imprevistos que, retomados e reinvestidos, passam a constituir uma nova racionalidade, de modo que ele continua operando para fins que não eram os seus na origem (FOUCAULT, 1998, p. 245). Não há, portanto, coincidência entre a urgência que o fez surgir e a função que ele acaba por cumprir.

São esses dois movimentos que permitem trazer o conceito a um documento. Pois um protocolo clínico é, à letra, um conjunto heterogêneo: articula enunciados científicos, recomendações de conduta, normas administrativas, fluxos de dispensação, decisões regulamentares e uma certa figura moral daquele a quem se dirige. É uma rede, não uma peça. E é, por sua própria forma, a resposta estratégica a uma urgência, epidemiológica, no caso. Resta saber o que ele, ao responder a essa urgência, faz existir; e se aquilo que nele se apresenta como proteção, como cuidado, como margem de liberdade reconquistada sobre o

risco, não é antes o ponto em que o registro contínuo anunciado no início vem, enfim, pousar sobre o corpo.

1.4. A PrEP PARA ADOLESCENTES: A AUTONOMIA COMO INSCRIÇÃO NO DISPOSITIVO

É preciso reconhecer que o PCDT assume posição importante na proteção em saúde pública no Brasil. Num país em que as desigualdades sociais são intensas e em que o acesso à saúde se distribui de modo desigual, a extensão da PrEP para adolescentes corresponde a uma urgência efetiva: diminuir vulnerabilidades e assegurar prevenção a jovens que, com frequência, não encontram apoio bastante na família, na escola ou nas instituições. Para isso, o protocolo precisa ser compreendido em seus vários sentidos: como um instrumento voltado ao cuidado, ao acesso e à redução de danos, mas também como parte integrante de uma rede mais ampla, que articula saberes, normas e práticas e que faz da sexualidade adolescente um objeto para atenção, acompanhamento e intervenção.

O Protocolo Clínico abre sua justificativa por um dado epidemiológico: os novos casos de aids, lê-se, “se concentram, majoritariamente, na população jovem (15 a 24 anos)” (BRASIL, 2025, p. 11). Lido de fora, o dado parece apenas localizar um grupo de risco já dado, ao qual a profilaxia viria responder. Mas é justamente esse o gesto que a analítica ensina a desconfiar. A epidemiologia não encontra o jovem como população de risco, ela o constitui como tal, faz dele uma superfície legível, um ponto onde incidir, antes que houvesse ali objeto a tratar. É a regra de imanência operando no documento: a sexualidade do adolescente só se torna algo a conhecer a partir das relações de poder que a instituíram, e o saber epidemiológico é a técnica pela qual o dispositivo pôde investir sobre ela (FOUCAULT, 1999, p. 93-94). A supressão, desde 2022, da indicação restrita às populações-chave confirma a lógica: segundo o PCDT, a profilaxia “não tem indicação restrita às populações-chave” e pode ser indicada a todas as pessoas a partir de 15 anos, com peso igual ou superior a 35 kg, em contexto de vulnerabilidade para aquisição do HIV (BRASIL, 2025, p. 12). Não se trata de fixar a fronteira entre quem pode e quem não pode, gesto que pertenceria à aliança, mas de estender sem cessar o domínio do controle: proliferar, anexar, alcançar. O protocolo anuncia ampliação do acesso. No registro do dispositivo, é ampliação do alcance.

Essa figura do jovem não nasce com o protocolo; tem genealogia. O próprio Foucault a inscreve entre os quatro grandes conjuntos estratégicos que, a partir do século XVIII,

montaram dispositivos de saber e poder sobre o sexo, a pedagogização do sexo da criança (FOUCAULT, 1999, p. 99). A criança, e o adolescente que dela se prolonga, não é o ser a quem a sexualidade falta ou de quem ela deve ser afastada; é aquele cujo sexo, reconhecido como ativo e ao mesmo tempo perigoso e natural, convoca em torno de si pais, médicos e educadores incumbidos de vigiar um germe tido por precioso e ameaçado (FOUCAULT, 1999, p. 29-36; 99). A criança masturbadora é a figura de saber que esse dispositivo produz. O critério de inclusão do protocolo a reescreve quase termo a termo: a profilaxia pode ser indicada a pessoas a partir de 15 anos, “sexualmente ativas” e em “contextos de vulnerabilidade acrescida” (BRASIL, 2025, p. 20). Sexo ativo e sexo perigoso reunidos na mesma cláusula. É a antiga figura que retorna. O que muda não é ela, mas o seu encarregado: onde a pedagogização distribuía a vigilância entre a família e a medicina, o protocolo a desloca, inteiramente, para o serviço de saúde.

Esse deslocamento se decide no ponto em que o protocolo toca a família, e a passagem está em 5.1.1. Aos adolescentes maiores de quinze anos, lê-se, “deve-se garantir o acesso a serviços, orientações e consultas de saúde sem a necessidade de presença ou autorização de pais ou responsáveis”; a profilaxia pode ser indicada “não sendo necessário o consentimento dos pais e/ou responsáveis” (BRASIL, 2025, p. 21). Para medir o que aí se passa, convém lembrar o lugar que a família ocupa na análise de Foucault: ela é o permutador da sexualidade com a aliança, o ponto por onde a lei e o jurídico passam ao dispositivo da sexualidade e a economia do prazer retorna ao regime da aliança (FOUCAULT, 1999, p. 102-103). Tudo o que se dissesse sobre a sexualidade do menor passava, historicamente, por esse permutador, era na família que o consentimento se ancorava, porque era ali que a aliança fixava quem tem autoridade sobre quem. Ao dispensar a autorização parental, o protocolo não amplia simplesmente um direito: ele desliga o permutador. Retira a sexualidade do adolescente do circuito da aliança, do pátrio poder, da guarda, da família como instância que autoriza, e a religa diretamente ao dispositivo da sexualidade: à relação médica, ao protocolo, ao acompanhamento. É a própria dobradiça entre os dois dispositivos posta a funcionar sobre um corpo determinado.

À primeira vista, esse gesto poderia ser lido como um conflito entre dois tipos de poder: de um lado, a norma jurídica ligada à família; de outro, a técnica médica voltada à sexualidade. O próprio documento, porém, não permite sustentar essa oposição de forma simples. O fundamento jurídico do destacamento não está fora do protocolo, a opor-se a ele, mas dentro

dele. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069 de 1990, que sustenta a autonomia reconhecida ao adolescente; e é o artigo 103 do Código de Ética Médica, que o próprio protocolo invoca, que veda ao médico revelar o segredo do paciente menor “inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo” (BRASIL, 2025, p. 21). O direito não comparece como interdição a ser vencida; comparece como tática a ser mobilizada. É a polivalência tática dos discursos: numa mesma estratégia coexistem discursos diferentes e até contrários, e um discurso jurídico que noutro arranjo diria não, a lei como linguagem do soberano, aqui produz acesso (FOUCAULT, 1999, p. 96-97). Não é por acaso que os exemplos de Foucault, ao formular a regra das variações contínuas, sejam justamente os pais e os médicos de um lado, os adolescentes e as crianças de outro: ele os nomeia para recusar a pergunta que os fixaria como quem detém e quem é privado do poder (FOUCAULT, 1999, p. 94-95). Não há, em lugar dessa repartição, donos e despossuídos. Há matrizes de transformação, e o protocolo é uma delas, a deslocar a autoridade sobre o corpo do adolescente de um registro a outro.

O mesmo deslocamento reaparece no estatuto do segredo. Na representação jurídico-discursiva do poder, aquela que o capítulo recusa, o segredo é a sombra para onde o sexo é empurrado a fim de ser negado; o ciclo da interdição culmina em relegá-lo à inexistência, à sombra, ao silêncio (FOUCAULT, 1999, p. 80-83). Sigilo, nesse quadro, é supressão. O protocolo o emprega em sentido exatamente inverso. O “direito à privacidade e sigilo” do adolescente, e o dever médico de não revelar o seu segredo mesmo perante os pais, não escondem a sua sexualidade para anulá-la: são a condição que o constitui como sujeito apto a entrar no dispositivo (BRASIL, 2025, p. 21). O segredo, aqui, não fecha o acesso, abre-o. É de novo a polivalência tática, que Foucault enuncia quase prevendo o caso: o silêncio e o segredo dão guarida ao poder e fixam suas interdições, mas também “afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias” (FOUCAULT, 1999, p. 96). O sigilo perante os pais é uma dessas tolerâncias. Não uma brecha no dispositivo, mas um de seus mecanismos.

Resta perguntar o que é esse sujeito e como o protocolo o obtém. A autonomia que ele reconhece não é incondicional: a profilaxia pode ser indicada sem o consentimento dos pais “desde que a pessoa tenha compreensão da profilaxia e seu acompanhamento”, e o Código de Ética exige do menor a “capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios” (BRASIL, 2025, p. 21). O protocolo não encontra um adolescente já

autônomo cuja liberdade lhe caberia respeitar, ele produz o sujeito autônomo na própria exigência de compreensão e de capacidade. A autonomia é efeito, não pressuposto. E é um efeito que vem amarrado: aquilo que se exige que o adolescente compreenda é a profilaxia e o seu acompanhamento, de modo que a condição da autonomia é o ingresso no monitoramento que não cessa. O próprio PCDT reforça essa amarra ao prever, para adolescentes, consultas de acompanhamento mais frequentes, meios remotos de acompanhamento, horário flexível, profissionais acessíveis, abordagem livre de julgamento e indagação sobre dúvidas e receios relativos à experiência sexual (BRASIL, 2025, p. 21). Aqui o capítulo reencontra o seu início.

Disso não se conclui que o direito do adolescente à profilaxia sem os pais seja uma cilada, nem que a sua autonomia seja ilusória. A advertência de método que percorre o capítulo vale também para o seu fim: o dispositivo não tem inventores hipócritas, suas estratégias são intencionais sem serem a decisão de um sujeito, e a liberdade que ele torna possível não é, por ser vivida como conquista, menos real. O que a análise mostra é outra coisa, e mais discreta. É que afirmar a sexualidade do adolescente, reconhecer-lhe a autonomia, garantir-lhe o sigilo não o coloca fora do poder que sobre ele se exerce, coloca-o, antes, “seguindo a linha do dispositivo geral de sexualidade” (FOUCAULT, 1999, p. 121). O protocolo estende esse dispositivo no gesto mesmo em que protege: produz o adolescente como sujeito autônomo, compreendente e acompanhado; desliga-o da aliança e o inscreve na sexualidade; faz do direito, do próprio Estatuto que o emancipa do pátrio poder, a tática pela qual essa inscrição se autoriza.

1.5. SÍNTESE

O capítulo se absteve de fixar o dispositivo antes de colocá-lo em funcionamento; preferiu deixá-lo atuar. Em dois domínios foucaultianos, a reforma penal e a sexualidade, o mesmo operador se encontrava em atividade antes de ser designado: uma rede heterogênea, a urgência que a chama, os efeitos que ultrapassam toda intenção (FOUCAULT, 1987; FOUCAULT, 1999). Sua nomeação, ao final, nada acrescentou ao PCDT sob a forma de uma chave exterior; tornou visível, isto sim, aquilo que o documento já punha em obra. Sob essa leitura, o protocolo deixa de aparecer apenas como peça técnica e passa a ocupar lugar em uma trama na qual se articulam saber, norma e cuidado (FOUCAULT, 1998, p. 244-246; BRASIL, 2025).

Sua versão já está fazendo o trabalho rítmico que conversamos, e os travessões saíram. As alternativas que você adotou (parênteses no aposto, dois-pontos na frase da analítica) cumprem bem a função, então as mantive. Fiz uma única intervenção, que explico abaixo.

No caso de sua aplicação ao PCDT, o conceito tampouco levou a uma denúncia, e seria apressado reconduzi-lo a esse plano. O que a análise tornou visível pertence a outra ordem, mais sóbria e, ainda assim, mais decisiva. O dado epidemiológico, em vez de apenas identificar um grupo de risco já dado, fez com que o jovem se constituísse como superfície de incidência (BRASIL, 2025, p. 11-12). A dispensa de autorização parental não significou apenas a extensão de um direito; ela suspendeu o ponto de passagem por onde a sexualidade do menor transitava pela família, para reconectá-la à relação médica (BRASIL, 2025, p. 20-21; FOUCAULT, 1999, p. 100-106). O fundamento jurídico (o Estatuto, o Código de Ética) não apareceu na figura de um limite a superar, mas de uma tática a ser mobilizada; o sigilo não surgiu como supressão, mas como condição de ingresso; a autonomia não entrou em cena como pressuposto a preservar, mas como efeito a ser produzido, inseparável de um acompanhamento que prossegue (BRASIL, 2025, p. 21; FOUCAULT, 1999, p. 88-100).

Em cada uma dessas passagens, o protocolo estende o dispositivo da sexualidade no próprio movimento com que protege. O dispositivo não remete a inventores hipócritas; aquilo que ele torna possível, ainda que vivido como conquista, não se torna por isso menos real. Reconhecer a relevância pública do protocolo e descrever os seus efeitos de subjetivação não são teses concorrentes: trata-se do mesmo objeto, apreendido em duas escalas. A analítica não opta entre cuidado e controle, porque essa oposição, aqui, perde consistência. Afirmar a sexualidade do adolescente permanece inscrito na linha do dispositivo que a organiza (FOUCAULT, 1999, p. 121).

Desse modo, o capítulo se fecha menos com uma conclusão do que com um deslocamento da pergunta: em vez de indagar se o adolescente é livre ou governado, importa examinar com que procedimentos ele se tornou, a um só tempo, uma coisa e outra. É essa figura, a do sujeito autônomo, compreensivo e acompanhado, que estará diante dos capítulos seguintes.

Segue a transcrição integral do arquivo enviado:

2. DISPOSITIVO DA AIDS

Antes mesmo de surgir a primeira palavra, a música já se impõe. Os sons graves se estendem e, sobre esse fundo, a voz do locutor cai densa, imediata, sem intervalo. A imagem escurece. Aquele que assiste ainda ignora o tema da reportagem e, no entanto, já é tomado pelo medo: há uma ameaça em cena, embora nada tenha ainda sido dito.

É para o perigo que a locução orienta o olhar. A atmosfera já está montada; a tragédia, uma vez mais, entra em apresentação¹.

As reportagens iniciais apoiavam-se, em primeiro lugar, na fala investida de autoridade do especialista: o jaleco, o microscópio, o gráfico, a expectativa de cura. A quantidade expressiva de cientistas entre os entrevistados, bem como a recorrência de signos associados à autoridade médica e laboratorial, fornecia sustentação à legitimidade do discurso científico no programa (BARATA, 2006, p. 107-112). Mas esse registro científico não aparecia sozinho; vinha ligado a uma música saturada de tensão, a uma narração em chave de alerta, a imagens escuras, a figuras bélicas e à associação reiterada da doença a determinados corpos, sobretudo os de homossexuais e usuários de drogas (BARATA, 2006, p. 109-116; p. 137-138). O paciente, por sua vez, podia aparecer como indivíduo reconhecível ou como figura sem identidade, segundo a lógica do enquadramento: no caso brasileiro, de modo particular, os pacientes eram com frequência exibidos sem rosto, sem nome ou por formas indiretas de identificação (BARATA, 2006, p. 132-138). Assim, aquilo que o Fantástico foi compondo ao longo da década não se reduz a um repertório de notícias: trata-se das imagens por meio das quais a aids se fez reconhecível no país — quem deveria inspirar temor, quem deveria ser exposto, quem deveria responder por ela (BARATA, 2006, p. 142-148).

A força da tese está, precisamente, em recusar a ideia de televisão como mero veículo entre o saber médico e o público. O que a cobertura produziu, naquela primeira década, não foi só a tradução de uma doença tomada como já existente, mas a própria constituição do horizonte de inteligibilidade em que ela pôde começar a ser pensada — e tal operação esteve longe de ser neutra. A autora considera a televisão como instância participante da construção da realidade social da aids, num contexto marcado por desinformação e por incertezas médicas, políticas e públicas a respeito da doença (BARATA, 2006, p. 12-15). Ao atribuir, quase

¹ música e a narração não funcionavam apenas como acompanhamento formal. A autora assinala que a sonoplastia reforçava “mistério”, “suspense” e tensão, orientando previamente a leitura emocional da reportagem. Nas primeiras matérias, esse efeito se combinava ao tom grave da narração e às imagens escuras, compondo uma atmosfera de medo e insegurança. Cf. BARATA, 2006, p. 109; p. 113-115.

sempre, ao cientista o lugar de fonte legítima, delimitou quem podia falar com autoridade sobre a aids (BARATA, 2006, p. 107-113; p. 144). Ao estabelecer quais pacientes teriam rosto e quais ficariam no anonimato, distribuiu de maneira desigual a visibilidade dos corpos (BARATA, 2006, p. 132-138; p. 143-144). Ao combinar música tensa, imagens sombrias e promessas de tratamento, modulou os afetos — medo, repulsa, compaixão, esperança — pelos quais o país recebeu a epidemia (BARATA, 2006, p. 109-116; p. 127-132). E, ao inscrever a doença em metáforas de guerra e na suspeita dirigida a homossexuais e usuários de drogas, converteu o adoecimento em marca de desvio (BARATA, 2006, p. 137-138; p. 145-146).

Tais efeitos não se limitavam ao momento em que a notícia era transmitida. Na medida em que a cobertura percorria etapas diversas — do mistério ao pânico, do pânico à acusação política, desta ao ensino da prevenção e, finalmente, à constituição de um espaço para a esperança terapêutica —, as classificações que ela mesma instituía não se dissipavam; ao contrário, adquiriam maior fixidez. A própria dissertação distingue movimentos sucessivos nessa cobertura: um primeiro, definido pelo medo e pela forte referência ao discurso científico; um segundo, caracterizado pela entrada do governo em cena e pela exposição das insuficiências da saúde pública; e um terceiro, marcado pela generalização da aids como problema de todos, com a passagem de "grupo de risco" a "comportamento de risco" (BARATA, 2006, p. 113-114; p. 124-128). É talvez aí que se encontre seu efeito de maior alcance. A aids se tornou compreensível precisamente porque foi conservada à distância: como algo que podia ser conhecido, visto e acompanhado, mas que permanecia sempre localizado na vida dos outros — em determinados corpos, em determinadas práticas. Essa distância se deixa perceber tanto na vinculação inicial da doença aos "grupos de risco" quanto no modo pelo qual o programa, mesmo quando informava, preservava uma cena marcada pelo medo, pelo anonimato e pela alteridade (BARATA, 2006, p. 114-116; p. 143-148). A inteligibilidade produzida pela mídia não trouxe a doença para perto do espectador; converteu-a, antes, em objeto de observação, resguardado pela tela. E uma doença aprendida sob essa forma deixa atrás de si categorias que não desaparecem quando a cobertura se desloca para outro assunto (BARATA, 2006, p. 145-148).

O que o Fantástico torna visível é o dispositivo que o capítulo anterior definiu como chave de leitura — agora no campo da epidemia de HIV/aids. O argumento que conduz as páginas seguintes pode ser enunciado desde logo, ainda que de maneira provisória: a aids não se

apresenta como uma entidade clínica autônoma, anterior aos discursos que a nomeiam e descrevem, mas como um acontecimento histórico que reúne, numa mesma configuração, saberes biomédicos, instituições do Estado, práticas de governo dos corpos e produções discursivas heterogêneas. Considerá-la como dispositivo implica recusar duas posições opostas e, no fundo, equivalentes: de um lado, a redução ao agente viral, que tenderia a supor uma epidemia inteiramente anterior ao modo como foi socialmente enquadrada; de outro, sua dissolução numa construção exclusivamente discursiva, que correria o risco de apagar a materialidade das pessoas atingidas e das tecnologias acionadas para administrá-las. O dispositivo designa, antes de tudo, esse ponto de cruzamento. É isso, precisamente, que este capítulo pretende examinar.

2.1. ENTRE OS JORNAIS FRANCESES

Nos estudos de Claudine Herzlich e Janine Pierret, conduzidos em perspectiva diacrônica e sustentados por documentação, são analisados seis jornais franceses entre 1982 e 1986. O interesse não se dirige à doença tomada isoladamente, mas ao processo pelo qual ela deixou de figurar como problema estritamente médico para tornar-se questão de vida social, publicamente reconhecida, discutida e apta a separar grupos e reconfigurar vínculos. A tese principal é enunciada sem rodeios: foi a imprensa que "fez existir a AIDS para o conjunto da sociedade" (HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 73). Essa tomada de posição prolonga a de Veron: "os acontecimentos sociais", afirma ele, "só existem na medida em que são moldados pela mídia" (1981 apud HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 73). Seria fácil ler essa proposição como aquilo que o parágrafo anterior precisamente rejeitava, isto é, como uma redução da doença ao discurso que a designa. Mas os materiais examinados não autorizam tal conclusão. O que se delineia, antes, é uma zona de cruzamento, indicada por Herzlich e Pierret quando assinalam interferências e movimentos de retorno recíproco pouco usuais "entre o conhecimento científico e o conhecimento comum" (2005, p. 72). A construção a que se referem não apaga o vírus nem os corpos; ela nomeia, antes, o ponto em que o saber biomédico, ao ingressar no domínio em que a sociedade se sabe concernida, retorna carregado de sentidos que lhe eram exteriores. É esse ponto, e não a doença em si nem um discurso reduzido à sua pureza, que o capítulo procura atingir.

A argumentação desenvolve-se segundo uma sequência processual. Herzlich e Pierret separam quatro momentos entre 1982 e 1986 e mostram, em cada um deles, os modos pelos quais a doença é pouco a pouco deslocada do universo médico para a cena pública. Desde o

começo, dois procedimentos estão em ação. O primeiro é a nomeação: as designações iniciais, "câncer gay" e "síndrome homossexual", associam a doença a um grupo específico antes mesmo de qualquer elucidação causal; quando a denominação médica AIDS se estabiliza, os valores negativos se transferem para o novo nome. O segundo é a enumeração: a circulação do número de casos e de mortes faz do crescimento uma evidência contínua e impõe a percepção de uma irreversibilidade, que as autoras condensam assim: "o acidente dura" (HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 79). Mas o operador decisivo está no deslizamento da noção de "grupo de risco": oriunda da epidemiologia moderna como associação probabilística, ela é vinculada, nos jornais, a categorias englobantes como "comunidade homossexual", tomadas como realidade homogênea, e termina por funcionar como nexo causal (HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 85). A noção, então, já não serve para indicar quem adoece, mas para indicar quem transmite; e é nessa inversão que o discurso moral encontra seu princípio organizador.

Ao término da leitura de Herzlich e Pierret, permanece uma figura bastante nítida: a de um discurso que se alimenta de si mesmo e se reproduz sem depender de um sujeito singular que o assuma, uma "palavra do outro" que se tornou, "à revelia de cada um, palavra de todos" (HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 96). Considerado do ponto de vista do dispositivo, esse mecanismo pode ser descrito de outro modo: não como ausência de autor, mas como dispersão da potência de enunciação por uma rede inteira de instituições, saberes e práticas que funcionam sem requerer um centro único. As noções que o atravessam, "grupo de risco" e "portador sadio", são, na formulação de Roqueplo retomada pelas autoras, "culturalmente habitáveis" (HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 95): elas favorecem elaborações que excedem muito o seu teor epidemiológico e configuram as entidades sobre as quais o discurso preventivo passa, então, a exercer sua ação. O que Herzlich e Pierret documentam, ainda que não o formulem nesses termos, é precisamente o trabalho do dispositivo: a produção, pelo próprio discurso, dos objetos que ele supõe apenas encontrar já constituídos.

Aquilo que Herzlich e Pierret identificaram na imprensa francesa encontra, no Brasil do mesmo período histórico, uma figura de interlocução bem definida: Néstor Perlongher, que publica, em 1987, pela Brasiliense, O que é AIDS. Não se trata apenas de uma mudança de cenário geográfico. Perlongher mobiliza de maneira direta noções que o texto francês opera sem torná-las explícitas: ao recorrer a Foucault, nomeia o "dispositivo da AIDS" e transfere o foco da análise da cobertura jornalística para o corpo, para o desejo e para o governo das

práticas sexuais dissidentes. É precisamente essa extensão do campo que interessa ao argumento deste capítulo.

Perlongher assinala que a doença "chegou ao Brasil nos braços da moda" (1987, p. 56): os primeiros casos surgem no final de 1982, mas é a morte do estilista Markito, descrita em detalhe pela imprensa, que desencadeia a primeira onda de medo. A partir daí, o que se produz já não pertence propriamente à ordem da informação, mas à do espetáculo. A televisão faz suceder imagens de jovens de mãos dadas e de corpos consumidos pelo sarcoma, panoramas do gueto e cenas de suplício hospitalar; e a iconografia médica, conclui Perlongher, "é terrorista" (1987, p. 62). O pânico, de seu lado, assume proporções excessivas: a comoção social excede largamente a incidência estatística efetiva, e a prevenção tende quase sem mediações a converter-se em repressão. As consequências aparecem com data e com rosto. Em junho de 1985, vinte e quatro garimpeiros homossexuais são expulsos de Serra Pelada, despidos e abandonados na Transamazônica em caminhões que traziam a faixa "Transporte Gay", nove dias depois de uma conferência médica sobre a AIDS. A enfermidade, inicialmente circunscrita ao espaço dourado do jet-set, nacionaliza-se e atravessa as barreiras de classe: ao final de 1986, 95% dos doentes provinham já das classes populares. O que Perlongher descreve, portanto, não é uma epidemia à qual a sociedade responderia, mas uma sociedade que, sob cobertura sanitária, se recompõe contra aqueles que dela dissidem.

Essa conclusão já distingue Perlongher de Herzlich e Pierret. Se, nas sociólogas, o olhar se mantém à distância, no ensaísta brasileiro há acusação e há implicação. A diferença, porém, não se reduz ao temperamento; ela diz respeito também à posição assumida e ao lugar a partir do qual se fala. A distância das autoras francesas permite captar a forma do mecanismo, vale dizer, o modo pelo qual um discurso produz seu objeto e o põe em circulação sem sujeito; o engajamento de Perlongher devolve a espessura material da operação, isto é, os corpos sobre os quais ela incide, assinalados por classe, por região e por violência de Estado. E o lugar não é secundário. A AIDS que se torna nacional e alcança as classes populares já não coincide com o objeto que a imprensa francesa ajudara a constituir, e o modelo preventivo importado dos Estados Unidos, concebido para um gueto gay de classe média, não encontra, no Brasil, as homossexualidades populares às quais pretende dirigir-se. É esse descompasso que mais importa ao argumento. Ele antecipa, em outra escala, o problema que este trabalho acompanha: um dispositivo de prevenção não intervém sobre populações previamente dadas,

mas sobre populações que precisa pressupor, e cuja realidade local pode escapar ao modelo que as designa.

2.2. NA ONDA DA MODA

A distinção última entre os dois textos está no modo como cada um chega ao fim. Herzlich e Pierret encerram o percurso sem fechá-lo propriamente: conservam em suspenso a pergunta acerca de se os doentes escapam à "palavra do outro" (2005, p. 96) e, ao mesmo tempo, assinalam o risco de que a AIDS venha a tornar-se metáfora "da morte inevitável daqueles que não estão armados para viver" (2005, p. 97). Não extraem daí nenhuma norma. A última frase do artigo enuncia antes um voto, e um voto que admite sua dificuldade: o de que uma doença pudesse continuar sendo apenas uma doença. Perlongher, por sua vez, se situa no extremo oposto. Ali onde as sociólogas interrompem o juízo, ele afirma, contra uma medicina que mede a vida unicamente por sua duração, o direito ao próprio corpo, a multiplicidade do desejo, uma vida contada também "em intensidade de gozo" (PERLONGHER, 1987, p. 110). Seu fecho, portanto, não se apresenta como interrogação, mas como lema: "Seria paradoxal que o medo da morte nos fizesse perder o gosto da vida" (1987, p. 111). Se um texto protege a doença contra a metáfora, o outro protege o desejo contra o medo. São, no entanto, duas preocupações que a análise do dispositivo deve manter reunidas.

O ponto em que Perlongher leva sua leitura a termo autoriza também o fechamento de uma primeira camada deste capítulo. Nos anos 1980, a aids aparece como acontecimento atravessado pelo pânico, pela moralização da homossexualidade, pela espetacularização promovida pela mídia e pela conversão do risco sanitário em ameaça sexual. A doença "chegou ao Brasil nos braços da moda", escreve Perlongher, ligada à morte de Markito e quase de imediato transformada em espetáculo de corpos, sarcomas, hospitais, guetos e imagens médicas que o autor caracteriza como "terroristas" (PERLONGHER, 1987, p. 56-62). Essa cena brasileira prolonga, em outro registro, o mecanismo descrito por Herzlich e Pierret: a aids deixa de consistir apenas em enigma médico e passa a ter existência social por intermédio da imprensa, da nomeação, da contagem dos casos e da fixação da ideia de "grupo de risco" (HERZLICH; PIERRET, 2005, p. 73-85). O que aí se constitui é uma primeira figuração do dispositivo da aids: dispersa, sem princípio unificador, articulada pelo saber médico, pela imprensa, pela moral sexual, pelo temor coletivo e pela identificação de corpos perigosos.

2.3. A SOCIEDADE

Ainda assim, aquela década não se deixa apreender somente sob o ângulo do medo. Ao mesmo tempo que a aids se convertia, no espaço público, em ameaça moral e sanitária, também se iam formando instituições e organizações capazes de encaminhar a epidemia por outra via política. De la Dehesa situa os primeiros casos brasileiros em 1982, no contexto da abertura democrática e do movimento sanitário, isto é, numa conjuntura na qual a saúde começava a afirmar-se como direito social e como dever estatal (DE LA DEHESA, 2017, p. 268-269). A criação do Centro de Referência e Tratamento em Aids, em São Paulo, em 1983, do GAPA, em 1985, da ABIA, em 1986, e do Pela Vidda, em 1989, indica que a resposta brasileira foi, desde o princípio, marcada por militância, solidariedade, participação social e denúncia do estigma (DE LA DEHESA, 2017, p. 270-271). A Constituição de 1988, assim como a instituição do SUS, inscreve essa articulação numa linguagem mais abrangente: saúde como direito, participação social e descentralização administrativa. Por isso, os anos 1980 precisam ser compreendidos como o momento de composição do dispositivo: aí se articulam medo, mídia, saber biomédico, homossexualidade, violência moral, sociedade civil, movimento sanitário e direito à saúde.

A passagem para os anos 1990 exige, então, um deslocamento conceitual. Em Segurança, território, população, Foucault move a análise do poder, afastando-a da noção de substância ou de propriedade e conduzindo-a para o exame de seus mecanismos concretos, isto é, para o "conjunto de mecanismos e de procedimentos" que operam no interior das relações sociais (FOUCAULT, 2008, p. 4-5). Nesse quadro, a segurança não suprime a soberania nem a disciplina; antes, reorganiza a relação entre ambas. Já não se trata apenas de proibir, punir ou corrigir indivíduos, mas de conduzir fenômenos coletivos por meio de séries, cálculos, probabilidades, médias e "limites do aceitável" (FOUCAULT, 2008, p. 8-11). A epidemia passa, desse modo, a ser tratada como questão de população: algo que se conhece por estatísticas, que se distribui em categorias de risco, que se acompanha por campanhas, que se regula por serviços e que se orienta por técnicas de prevenção. Governamentalidade designa precisamente essa racionalidade por meio da qual o dispositivo da aids se recompõe sem depender de um sujeito central: o Estado não comanda a rede a partir de fora, mas passa a atuar como um de seus nós mais relevantes, articulando saber epidemiológico, políticas públicas, ONGs, financiamento internacional, protocolos e práticas de cuidado. Nos anos 1990, tal inflexão se materializa na resposta brasileira por meio do Programa Nacional de

DST/AIDS, da unidade de articulação com ONGs, dos empréstimos do Banco Mundial e da ampliação de projetos de prevenção, contratos, editais, agentes multiplicadores e ações dirigidas às populações consideradas vulneráveis (DE LA DEHESA, 2017, p. 274-282). O dispositivo, portanto, não perde força quando abandona o registro do pânico moral; ao contrário, torna-se mais complexo e passa a penetrar mais profundamente a vida cotidiana, pela prevenção, pela responsabilização e pela produção de sujeitos chamados a reconhecer, calcular e gerir o próprio risco.

É nesse registro que convém compreender a década de 1990. O que então se delineia não é, pura e simplesmente, "o governo" na posição de sujeito soberano que comandaria a epidemia, e sim um modo mais espesso de coordenação estatal de uma rede cuja formação vinha dos anos precedentes. De la Dehesa indica que, com a volta de Lair Guerra ao Programa Nacional de DST/AIDS, em 1992, com a instalação de uma instância de articulação com ONGs e com os empréstimos do Banco Mundial — sobretudo o AIDS I, no período de 1994 a 1998 —, a resposta brasileira à aids se recompõe mediante contratos, financiamento, projetos, critérios técnicos, prevenção e participação da sociedade civil (DE LA DEHESA, 2017, p. 274-281). A isso se soma a política de distribuição gratuita de medicamentos, adotada em escala nacional em 1993 e elevada à condição de política de Estado pela lei de 1996, movimento que inscreve a resposta brasileira em uma linguagem de direito à saúde e de dever público de cuidado (DE LA DEHESA, 2017, p. 275). Desse modo, a epidemia passa a ser governada por uma racionalidade própria: não somente repressão ou medo, mas gestão de populações, financiamento de iniciativas preventivas, delimitação de públicos-alvo, produção de agentes multiplicadores e responsabilização dos sujeitos diante do risco.

É por essa razão que De la Dehesa não deve ser tomado apenas como referência de contexto, mas como peça decisiva para a reconstrução genealógica. O que seu artigo torna visível é que, ao longo dos anos 1990, a resposta brasileira à aids se organiza em torno de uma modalidade determinada de governamentalidade: o Estado amplia sua capacidade de coordenação, mas o faz por meio de uma trama que articula Programa Nacional de DST/AIDS, SUS, ONGs, movimentos sociais, recursos internacionais e organismos multilaterais. A volta de Lair Guerra ao Programa Nacional, em 1992, a constituição de uma instância de ligação com ONGs e os financiamentos do Banco Mundial, inaugurados com o AIDS I, entre 1994 e 1998, não significaram apenas expansão orçamentária; assinalaram a consolidação de uma tecnologia administrativa da prevenção. A epidemia passa, então, a ser

conduzida por contratos, editais, metas, relatórios, parâmetros técnicos, agentes multiplicadores e projetos dirigidos a grupos definidos como vulneráveis. Ao mesmo tempo, a política de acesso gratuito aos medicamentos, adotada nacionalmente em 1993 e, com a lei de 1996, convertida em política de Estado, inscreveu a resposta brasileira na linguagem do direito à saúde. O efeito é uma configuração ambivalente: as ONGs se fortalecem como parceiras e interlocutoras, mas também se tornam dependentes de financiamento, prestação de contas e critérios de gestão. A sociedade civil não desaparece; ela é incorporada ao próprio funcionamento governamental da epidemia.

A estrutura institucional que se consolida nos anos 1990, entretanto, não surge sem história prévia. Seu suporte está na rede formada na década anterior, quando a resposta brasileira à aids se vinculou ao movimento sanitário, ao processo de redemocratização e à afirmação da saúde como direito. De la Dehesa mostra que os primeiros casos no Brasil, registrados em 1982, aparecem no contexto da abertura democrática e da crítica ao modelo autoritário de saúde, no mesmo processo que levaria à Constituição de 1988 e ao estabelecimento do SUS, fundado nos princípios da universalidade, da descentralização e da participação social (DE LA DEHESA, 2017, p. 268-269). Nesse quadro, a criação do GAPA, em 1985, o surgimento da ABIA, no ano seguinte, a formação do Pela Vida, em 1989, e dos ENONGs mostram que a sociedade civil não foi um acréscimo tardio à política estatal, mas uma de suas condições de possibilidade (DE LA DEHESA, 2017, p. 270-271). O Projeto Previna, lançado em 1989, já sinaliza esse deslocamento ao instituir comitês compostos por técnicos e ativistas, produzir materiais de prevenção e converter populações antes definidas como "vetores de transmissão" em "vetores de conhecimento", por meio de educadores pares e agentes multiplicadores (DE LA DEHESA, 2017, p. 272-273). Assim, antes mesmo da plena racionalidade governamental dos anos 1990, já se desenhava uma tecnologia preventiva apoiada na participação das próprias populações mobilizadas.

Nos anos 1990, porém, essa rede passa a adquirir contornos mais nítidos como modalidade de governamentalidade. A volta de Lair Guerra ao Programa Nacional de DST/AIDS, em 1992, marca uma virada importante: em sua segunda administração, constitui-se uma instância voltada à articulação com ONGs e elabora-se a carta de intenções que estaria na origem do primeiro empréstimo do Banco Mundial, o AIDS I, vigente entre 1994 e 1998, com 250 milhões de dólares destinados à resposta brasileira, sendo 40% dirigidos à prevenção (DE LA DEHESA, 2017, p. 274-275). Ao mesmo tempo, a política brasileira preserva um traço

próprio, que não se deixa reduzir à agenda do Banco Mundial: a oferta gratuita de medicamentos em escala nacional, adotada em 1993, converte-se, por força de lei, em política de Estado em 1996, inscrevendo o combate à aids na linguagem do direito à saúde (DE LA DEHESA, 2017, p. 275). A singularidade do modelo brasileiro reside justamente nessa composição, que articula, por um lado, participação social, SUS e universalidade, e, por outro, financiamento internacional, gestão por projetos, descentralização, eficiência administrativa e focalização preventiva. Nessa configuração, o Estado não surge como instância soberana que, sozinha, domina a epidemia, mas como núcleo de coordenação de uma rede que reúne burocracia sanitária, ONGs, organismos internacionais, saber epidemiológico e populações vulneráveis.

No final dos anos 1990, essa arquitetura ganha a forma mais definida de uma governança em rede. O Banco Mundial não apenas fornece recursos, mas também participa da instituição de mecanismos competitivos para a contratação de ONGs, com avaliação externa das propostas, critérios gerenciais, epidemiológicos ou geográficos, relatórios trimestrais e visitas técnicas de monitoramento (DE LA DEHESA, 2017, p. 280-281). No AIDS I, foram contratadas 181 ONGs para 584 projetos, dos quais 444 correspondiam à prevenção; no AIDS II, 795 ONGs executaram 2.163 projetos, sendo 1.709 preventivos (DE LA DEHESA, 2017, p. 281). A prevenção passa, então, a operar como técnica administrativa e subjetiva: administra recursos, populações ou territórios, mas também produz sujeitos capazes de reconhecer-se sob risco, aderir ao sexo seguro e fazer circular informação. O Projeto Somos, lançado em 1999 em parceria com a ABGLT, torna essa racionalidade mais visível ao definir ONGs mais estruturadas como centros regionais de capacitação, aos quais cabia fortalecer organizações menores, criar novas entidades e promover ações voltadas a homens que fazem sexo com homens. Seu objetivo não consistia apenas em informar, mas em produzir "ambientes favoráveis", enfrentar a homofobia, promover cidadania, autoestima e sexo seguro (DE LA DEHESA, 2017, p. 282). É nesse ponto que se abre a passagem para Pelúcio e Miskolci: se De la Dehesa recompõe a arquitetura institucional da prevenção, Pelúcio e Miskolci permitem examinar os seus efeitos subjetivos — isto é, a constituição de um sujeito preventivo, responsabilizado, racionalizado e chamado a governar-se.

2.4. SIDAnização

Depois de completada essa engrenagem institucional, importa transferir o foco da análise para os efeitos que ela produz na esfera da subjetividade. Se De la Dehesa torna visível a

estabilização da prevenção por intermédio do Estado, das ONGs, do Banco Mundial, dos contratos, dos editais e dos agentes multiplicadores, Pelúcio e Miskolci permitem compreender que espécie de sujeito é produzida por essa racionalidade: um sujeito convocado a reconhecer-se como estando em risco, a ordenar a própria conduta, a conformar-se ao sexo seguro e a tomar para si a responsabilidade por sua saúde. É nesse ponto, precisamente, que a governamentalidade dos anos 1990 encontra, nos anos 2000, sua forma subjetiva mais nítida: a SIDAanização.

É essa articulação entre planos distintos que Larissa Pelúcio e Richard Miskolci procuram estabelecer em um texto de 2009, já passadas duas décadas de Perlongher e já instalada a distância necessária para que o dispositivo deixe de aparecer apenas como pânico a ser denunciado e possa ser tratado como mecanismo a ser analisado. O passo adiante dado pelos autores não está, propriamente, em oferecer uma nova descrição da epidemia, mas em nomear aquilo que os trabalhos anteriores haviam tangenciado sem separar com clareza: o centro operativo do dispositivo da aids reside no discurso da prevenção, e não na doença em si mesma. Daí decorrem consequências precisas. Se Herzlich e Pierret haviam assinalado a conversão da doença em fato público, e se Perlongher havia denunciado o emprego dessa conversão contra os dissidentes, Pelúcio e Miskolci mostram que o dispositivo, em regra, não atua por meio da proibição direta "antes controla e produz verdades moldando subjetividades [...] marcadas pela culpa e pela impureza, sintetizadas nos seus desejos tomados como ameaçadores da ordem social" (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 130). O que se governa, assim, não são os corpos de maneira imediata, mas os sujeitos que os habitam — sujeitos levados a interpretar o próprio desejo como perigo. E o princípio que estrutura esse aprendizado tem um nome: heteronormatividade, compreendida não como coerção externa, mas como finalidade já interiorizada no sujeito, uma imposição orientada para uma "compreensão futura da vida como monogâmica, reprodutiva, familiar, em suma, privada e sob controle" (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 142-143). Sob esse ângulo, a epidemia de aids não interrompeu a longa trajetória de patologização das sexualidades dissidentes aberta no século XIX; antes, forneceu a ocasião para que ela fosse reativada em uma gramática epidemiológica.

Mas essa reativação não se reduz à troca da linguagem clínica pela linguagem epidemiológica; ela envolve a produção de um novo tipo de sujeito. O mecanismo que Pelúcio e Miskolci chamam de "SIDAanização" designa justamente esse processo — a

incorporação dos alvos à ordem normativa por meio do discurso preventivo, fundada na adesão a princípios "como a 'individualização' e a 'racionalização'" e, sobretudo, a "responsabilização do sujeito no que se refere à saúde" (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 139). O sujeito sidadanizado não é apenas objeto de interdição: ele é reconduzido. Aprende a vigiar a si mesmo, a regular por conta própria o desejo e, caso fracasse — isto é, caso seja contaminado —, a ler o próprio fracasso como sinal de irresponsabilidade (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 138). Essa recondução, contudo, não se distribui de maneira homogênea. Os autores mostram que o dispositivo funciona seletivamente: as normas sociais vêm sendo "aplicadas mais a alguns do que a outros", de modo que aqueles que organizam a sexualidade fora dos padrões dominantes passam a receber uma exigência de controle e de racionalização que não incide sobre os que se ajustam à norma (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 143-144). Tal seletividade não é acidental, mas estrutural. E sua consequência mais precisa é aquilo que os autores designam como uma "ironia mortal": a ênfase preventiva se concentra no sexo público e não heterossexual "deixou escapar onde provavelmente se dá a maioria das contaminações, ou seja, as relações privadas, estáveis e possivelmente reprodutivas" (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 153). A heterossexualidade reprodutiva, por sua vez, permanece menos como objeto declarado da prevenção do que como seu horizonte silencioso.

Com apoio em Nikolas Rose, pode-se traçar com mais nitidez a passagem da SIDAdanização para a autovigilância. Em *Governing the Soul*, a condução de si não aparece como simples assimilação psíquica de mandamentos vindos de fora, mas como efeito de saberes, técnicas e modalidades de expertise que convertem a subjetividade em terreno de intervenção. O sujeito moderno é interpelado a interpretar a si mesmo, avaliar as próprias condutas, corrigir aquilo que toma como desvio e orientar a existência segundo valores que se apresentam sob os nomes de liberdade, autonomia, responsabilidade e cuidado de si (ROSE, 1999). Quando essa grade é deslocada para o dispositivo da aids, torna-se possível perceber que a prevenção não atua somente ao enunciar condutas, classificar grupos de risco ou dispor serviços; ela intervém, além disso, ao ensinar o sujeito a apreender sua sexualidade como domínio de cálculo, suspeita, vigilância e administração.

É sob esse ângulo, portanto, que se deve ler o artigo de Silva e Monteiro. A regulação do risco entre jovens gays e bissexuais não interessa, aqui, como chave explicativa do comportamento diante do HIV, mas como manifestação concreta de uma racionalidade

preventiva historicamente produzida. Os jovens entrevistados dominam os meios de prevenção e transitam entre preservativo, PrEP, PEP, testagem e janela imunológica; nem por isso suas decisões deixam de ser moduladas por vínculos, confiança, pactos afetivo-sexuais, aparência do parceiro, temor do estigma e proximidade com pessoas vivendo com HIV/aids (SILVA; MONTEIRO, 2026). A prática reiterada da testagem, que os autores caracterizam como "autovigilância sorológica associada a gestão do risco" (SILVA; MONTEIRO, 2026, p. 15), torna visível esse deslocamento: o sujeito não apenas recebe informações do dispositivo, mas passa a voltar-se sobre si mesmo, buscando verificar sua condição, diminuir margens de incerteza, reordenar práticas e refazer sua percepção da vulnerabilidade. Nesse plano, o comportamento não figura como causa primeira da vulnerabilidade; ele é, antes, a superfície em que se inscreve uma história mais longa de moralização, prevenção, biomedicalização e responsabilização.

O ponto cego, aqui, não é defeito do dispositivo; é, propriamente, um modo de funcionamento. O que o percurso analítico deste capítulo deixa ver — da nomeação jornalística examinada por Herzlich e Pierret ao pânico sanitário denunciado por Perlongher, da SIDAanização descrita por Pelúcio e Miskolci à seletividade que regula sobretudo quem permanece fora da norma — é que o discurso preventivo jamais incidiu sobre populações previamente constituídas, mas sobre populações que antes precisava produzir. Seguindo esse encadeamento, o PCDT de 2025 não se afasta da lógica acompanhada ao longo do capítulo: ele a herda e a reorganiza. O adolescente que o documento constitui como sujeito vulnerável à aids antes mesmo de torná-lo elegível à PrEP, bem como a seção que garante sigilo e dispensa o consentimento dos pais, mostram que o dispositivo continua a pressupor uma população cuja sexualidade não coincide com o modelo que a designa. A defasagem assinalada por Perlongher entre o modelo preventivo importado e as homossexualidades populares brasileiras retorna, em outra escala e sob outra temporalidade, na distância entre o adolescente pressuposto pelo PCDT e aquele que o protocolo efetivamente encontra nos serviços de saúde. A defasagem não se extinguiu; apenas tomou outra configuração.

3. PESSOAS JOVENS

Tratar a adolescência como etapa natural do desenvolvimento humano implica admitir que essa noção designa apenas um substrato biológico prévio. A condição que se ergue sobre esse substrato, porém, já é obra social, a começar pelo traço que parece defini-la: o tempo protegido. Esse tempo não equivale simplesmente à isenção ou à ausência de trabalho. Ele

produz um modo próprio de experiência. É esse modo que Bourdieu e Passeron analisam em *Os herdeiros* (1964), ao tratarem da situação estudantil francesa do começo dos anos 1960, na qual a proteção característica da infância se prolonga para além dela. Mas os autores mostram que essa situação não conduz, de maneira uniforme, a uma existência lúdica e separada das imposições do mundo real. Viver os estudos como tempo em suspenso depende de amparo material (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 28, 32, 48 a 50). Sob a designação comum de “sério” cabem, assim, duas maneiras de viver a mesma condição. De um lado estão, sobretudo, os estudantes de origem burguesa, que podem fazer dos estudos uma experiência relativamente afastada das urgências da subsistência. De outro, estão os que estudam sob a pressão da necessidade (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 28, 32, 49 a 51). Essa relação desobrigada com o aprendizado apoia-se no que os autores chamam de “má-fé coletiva”: certos estudantes conseguem “dissimular a si mesmos a verdade de seu trabalho presente dissimulando o futuro ao qual ele prepara” (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 64). A formação passa, então, a ser vivida como fim que basta a si mesmo. Esse gesto implica privilégio de classe, porque, sendo transitória por definição, a condição estudantil recebe sua seriedade objetiva do destino profissional que prepara (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 58, 64). Desligar-se dessa referência é privilégio de quem tem a subsistência garantida por outro meio.

Esse privilégio quase nunca aparece como privilégio para quem dele dispõe. Bourdieu e Passeron indicam que a relação com o futuro escolar se modifica segundo as chances objetivas próprias de cada grupo. Para o filho de quadro superior, formado num meio em que percursos universitários são mais que comuns, os estudos superiores assumem a forma de um “destino banal e cotidiano”. Para o filho de operário, que só tem deles um conhecimento indireto, eles continuam sendo um horizonte externo (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 43 a 44). Desse modo, a desigualdade de acesso se prolonga em desigualdade de expectativa. A probabilidade objetiva própria de cada classe vira familiaridade num caso e distância no outro. Mas a seleção que leva até esse ponto não se reduz ao plano econômico. Os autores sustentam que os obstáculos materiais, por si sós, não bastam para dar conta de taxas tão desiguais de eliminação escolar entre as classes (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 23), porque a triagem passa também por barreiras simbólicas, e essas barreiras atingem quem não recebeu por herança os códigos da cultura dominante. Essa herança permanece invisível para a escola. É justamente essa cegueira diante das desigualdades sociais que lhe permite converter desigualdades de êxito em desigualdades tidas como

naturais, isto é, em “desigualdades de dons” (BOURDIEU; PASSERON, 2014 [1964], p. 39, 41, 45). Nesse ponto, o privilégio de pertencimento de que Weber fala encontra seu acabamento simbólico: para funcionar de maneira durável, a vantagem herdada precisa aparecer como qualidade da própria pessoa.

O que Bourdieu e Passeron descrevem no plano da distribuição, isto é, quem pode viver a juventude como tempo em suspenso, ainda não explica o que constitui essa condição. Resta perguntar o que faz de alguém um menor. É nessa pergunta que se situa a interpretação que Bernard Stiegler oferece das gerações jovens. Para Stiegler, o que distingue o menor do adulto não se reduz a um limiar fisiológico. Trata-se da aquisição social de uma capacidade de responsabilidade. Os menores recebem esse nome porque cabe à sociedade adulta cuidar para que passem à maioridade, sobretudo pela educação, entendida como transmissão da competência social que leva à maturidade (STIEGLER, 2010, p. 1 a 2). Reaparece aí, em registro técnico e organológico, a definição kantiana do Esclarecimento como saída da menoridade. Tornar-se adulto quer dizer aprender a usar o próprio entendimento, o que exige a formação da atenção, da leitura, da escrita e da razão pública, e não um amadurecimento espontâneo do corpo (STIEGLER, 2010, p. 17 a 21).

A maturidade, nesse quadro, não é um dado. É uma aquisição historicamente situada, transmitida entre gerações por sistemas de cuidado e por instituições programáticas. A educação pública é, entre elas, o exemplo mais claro. É nesse espaço que a atenção se torna faculdade ao mesmo tempo psíquica e social, já que sua formação depende da sedimentação de retenções, da transmissão intergeracional da experiência e da inscrição do indivíduo em circuitos coletivos de individuação (STIEGLER, 2010, p. 6 a 8; p. 17 a 18; p. 29; p. 58 a 60). Assim, a juventude não encontra na natureza uma imaturidade já dada, que bastasse proteger ou resguardar. Ela se produz dentro de um dispositivo formativo que institui, transmite e estabiliza modos de atenção, responsabilidade e pertencimento geracional.

O outro lado desse processo aparece quando Stiegler examina as psicotecnologias contemporâneas. Ao capturar desde a infância a atenção das gerações jovens, as indústrias culturais e programáticas disputam com a escola a formação da atenção e podem destruir as condições que tornam essa formação possível. A atenção, que deveria constituir consciência, cuidado e responsabilidade, passa a ser objeto de captura, hiperestimulação e curto-circuito dos vínculos intergeracionais. É nesse sentido que Stiegler fala em destruição industrial da consciência, déficit de atenção em escala global e mutação geracional que converte a atenção

profunda em hiperatenção (STIEGLER, 2010, p. 54 a 57; p. 72 a 73). O que parece nomear uma etapa natural da vida mostra-se, nesse nível, como efeito de uma organização institucional e técnica da atenção. A categoria não descobre no jovem uma condição que já estivesse lá; ela a produz, ao transformar em atributo da idade aquilo que corresponde, antes de tudo, a uma posição constituída por instituições, saberes, tecnologias e regimes de transmissão.

Se a atenção é aquilo que as instituições formam e que as indústrias capturam, ela também se torna aquilo cuja falta a escola contemporânea aprendeu a nomear em léxico clínico. Ao examinarem o uso de metilfenidato para TDAH no espaço escolar, Mazon e Tholl indicam que a escola pode atuar como ponto de articulação entre pedagogia, psiquiatria e medicamento, isto é, como o lugar no qual dificuldades de atenção, agitação e aprendizagem passam a ser convertidas em problemas clínicos e em objetos de intervenção especializada (MAZON; THOLL, 2022, p. 47, 50 a 51, 60).

O que importa aqui não é a adolescência em termos gerais, nem uma denúncia simples do uso de medicamentos. Trata-se de observar a maneira pela qual certas condutas infantis passam a ser interpretadas segundo uma expectativa institucional que exige concentração, silêncio, rendimento e controle corporal. A figura do aluno agitado, disperso ou lento torna-se inteligível no interior de uma norma escolar que compara ritmos, hierarquiza comportamentos e legitima encaminhamentos. Assim, o metilfenidato aparece menos como algo externo à escola do que como uma tecnologia capaz de regular o fluxo cotidiano na sala de aula e produzir a “sala tranquila” esperada pelos professores (MAZON; THOLL, 2022, p. 65). A criança, o jovem ou o aluno não são apenas identificados pela instituição escolar. Podem também ser tecnicamente recompostos por ela, quando dificuldades na conduta ou na aprendizagem são transformadas em problemas próprios à intervenção especializada. Vistos em conjunto, os três planos sustentam uma mesma hipótese: a condição juvenil não precede as instituições que dela se ocupam. Ela se constitui na desigualdade com que é vivida, nos circuitos que formam sua atenção e sua responsabilidade e nas tecnologias, inclusive farmacológicas, que a recompõem quando ela deixa de corresponder ao que dela se espera.

3.1. BIOLÓGICOS E CULTURAIS

O que o texto de Hall estabelece não é apenas uma descrição do jovem, mas as condições de sua constituição como objeto científico e administrável. Ao inscrever a adolescência na

história natural do crescimento, segundo a matriz recapitulacionista pela qual o desenvolvimento individual repetiria, em alguma medida, a história da espécie, Hall desloca a juventude para o interior de uma gramática biológica da maturação (HALL, 1904, p. 1-2). As mensurações de altura, peso e ritmo de crescimento, apoiadas em grandes séries estatísticas e comparações antropométricas, não funcionam apenas como registro de uma realidade prévia; elas organizam um intervalo entre puberdade e maturidade, identificando nele uma aceleração corporal específica e uma descontinuidade a ser conhecida (HALL, 1904, p. 6-11, 18). É nesse horizonte que a adolescência pôde ser lida como fase de intensificação, instabilidade e governo. A fórmula que Mead atribui à tradição de Stanley Hall, uma adolescência marcada pelo florescimento do idealismo, pela rebelião contra a autoridade e por conflitos tomados como inevitáveis, explicita o modo como a crise adolescente foi naturalizada como "tempestade e tensão" (MEAD, 1928, p. 2, 197). A ameaça que atravessa esse discurso é, ao mesmo tempo, fisiológica, moral e civilizacional, e é essa sobreposição que permite reunir psicologia, pedagogia, antropometria e administração escolar em torno de um único objeto. Reconhecer e governar aparecem, assim, como movimentos inseparáveis: a energia adolescente precisa ser descrita em sua particularidade justamente para que possa ser dirigida, sublimada e disciplinada. A adolescência que Hall quer preservar é, página após página, a mesma adolescência que seu discurso ajuda a fazer existir.

O que essa operação torna visível não pertence apenas ao momento inaugural em que a adolescência foi inscrita na linguagem da biologia, da psicologia e da pedagogia. Em outro registro, Mazon e Caponi permitem perceber sua atualização contemporânea no modo como a infância se converte em domínio de saberes expertos, atravessado por práticas psicopedagógicas, diagnósticas e médicas que não apenas respondem a dificuldades previamente dadas, mas também definem os termos em que tais dificuldades podem aparecer como problemas de intervenção (MAZON; CAPONI, 2022, p. 1-2). Não se trata de equiparar infância e adolescência, nem de reduzir todo saber especializado a uma forma simples de dominação; trata-se, antes, de notar que os recortes etários ganham espessura institucional quando passam a ser acompanhados por vocabulários técnicos, critérios de avaliação, dispositivos escolares e formas autorizadas de cuidado. A criança descrita, avaliada e encaminhada por esses saberes não é apenas reconhecida em sua particularidade: ela é também produzida como sujeito de aprendizagem, de risco, de tratamento ou de prevenção. Desse modo, a aparência natural das idades da vida começa a se desfazer, pois aquilo que parece derivar imediatamente do corpo depende, para se estabilizar socialmente, de

instituições, classificações e práticas que tornam certos sujeitos visíveis como crianças, adolescentes ou jovens.

A contestação que se segue não incide apenas sobre os resultados de Hall, mas sobre a linguagem explicativa que os tornava possíveis. Na obra publicada originalmente em 1911 e revista em 1938, Franz Boas desmonta as bases raciais do evolucionismo ao recusar a passagem automática entre diferença cultural e inferioridade biológica. Para Boas, os feitos culturais de um povo não autorizam, por si mesmos, a conclusão de que uma raça seja mais dotada que outra; ao contrário, os acontecimentos históricos e as condições externas são mais decisivos para explicar os diferentes percursos de desenvolvimento cultural do que uma suposta faculdade inata das raças (BOAS, 1938, p. 16). Do mesmo modo, tipo físico, língua e cultura não formam uma unidade necessária e permanente, o que inviabiliza a classificação hierárquica dos grupos humanos como se cada forma cultural exprimisse diretamente uma essência racial (BOAS, 1938, p. 145-147). Esse deslocamento não suprimiu a exigência de conhecer o jovem; alterou o dispositivo em que esse conhecimento se deixava ordenar, substituindo a hierarquia racial pelo particularismo histórico e pela atenção à plasticidade das formas humanas.

É sobre esse fundamento que Margaret Mead parte para Samoa, em 1925, levando consigo uma indagação precisa: se as perturbações descritas pela tradição halliana fossem efeito de uma configuração cultural específica, seria de esperar que não aparecessem, ou não aparecessem do mesmo modo, em uma sociedade organizada de maneira profundamente diversa. A própria Mead formula sua pesquisa nesses termos ao perguntar se as perturbações que afligem os adolescentes derivam da natureza da adolescência ou da civilização em que ela se desenrola (MEAD, 1928, p. 11). A resposta encontrada em campo foi negativa para a universalização da crise: entre as jovens samoanas, a passagem pela puberdade não produzia uma ruptura psicológica decisiva, mas se integrava a um amadurecimento gradual, no qual as diferenças corporais não eram acompanhadas por uma reorganização dramática da personalidade (MEAD, 1928, p. 195-197). Por isso, o "storm and stress" deixava de aparecer como destino da condição humana e passava a ser lido como efeito de uma forma particular de organização social. A adolescência, em Mead, não desaparece; ela perde o estatuto de natureza universal e se torna uma relação historicamente configurada entre corpo, cultura, educação e conflito.

3.2. CONSTRUÇÃO HISTÓRICA

Reintroduzir a adolescência no horizonte de observação do Ocidente, ainda assim, não faz desaparecer o problema; apenas transfere o lugar em que ele se deixa perceber. Ao examinar as representações medievais da criança e do jovem, Ariès indica que as distinções etárias próprias da modernidade foram o produto de uma elaboração histórica demorada, destituída de plano prévio, cujos começos dificilmente permitiriam entrever a configuração que, ao final do percurso, se formaria. A ideia de adolescência já estava, em verdade, registrada no sistema medieval das idades da vida: *Le Grand Propriétaire de Toutes Choses*, enciclopédia latina compilada no século XIII e impressa em 1556, situava a adolescência após os sete anos e estendia sua duração até os vinte e um ou os vinte e oito, conforme as autoridades invocadas, caracterizando-a porque “a pessoa é bastante grande para procriar” (ARIÈS, 1981, p. 7). Esse esquema, porém, pertencia a uma ordem cosmológica sem proximidade com o sentido moderno do termo, já que a mesma organização ordenava simultaneamente o movimento dos astros, os humores do corpo e o destino dos homens (ARIÈS, 1981, p. 6); desse modo, as idades da vida não nomeavam etapas do desenvolvimento individual, mas relações de correspondência entre o microcosmo humano e a ordem do universo. Em consequência, a adolescência medieval não aparecia como um momento de progressão rumo à autonomia; definia-se, antes de tudo, pela posição que ocupava no interior de um sistema de interdependências.

Aquilo que desfaz, portanto, a aparência de naturalidade associada aos recortes etários da modernidade não deriva propriamente dessa cosmologia, e sim do princípio segundo o qual a própria infância podia ser classificada. Ariès observa “ninguém teria a ideia de limitar a infância pela puberdade”, pois a ideia de infância se ligava à situação de dependência, e não a um dado biológico (ARIÈS, 1981, p. 17); observa, além disso, “até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância”, já que *puer* e *adolescens* eram empregados sem diferenciação no latim escolar (ARIÈS, 1981, p. 14). Dito de outro modo, uma existência dividida em fases cronológicas nitidamente apartadas, assinaladas por limiares aos quais se atribuem diferenças psicológicas e capacidades em progressão, está longe de constituir evidência imediata. Trata-se, mais propriamente, de um produto de elaboração histórica da percepção do tempo individual, elaboração que apenas se tornou viável quando a disciplina dos registros paroquiais, imposta na França desde Francisco I e verificada no século XVIII, converteu a data de nascimento em componente da identidade civil (ARIÈS, 1981, p. 2).

Desse modo, na genealogia reconstruída por Ariès, aquilo que os dispositivos normativos contemporâneos tomam como cortes etários fundados em realidade biológica mostra-se, em vez disso, como constituição de uma realidade normativa, algo para o qual a biologia, por si só, nada oferece.

Tomada como categoria relativamente independente, a adolescência está muito distante de ser um fato natural; ela deve ser compreendida, antes, como uma construção histórica, cujo aparecimento pode ser localizado em um tempo preciso. Ariès sustenta que “a cada época corresponderiam uma idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana” (ARIÈS, 1981, p. 25): no século XVII, a idade investida de valor modelar seria a juventude; no XIX, a infância; no XX, a adolescência. Sempre que uma determinada etapa da vida é destacada e elevada a uma posição de centralidade, organiza-se ao seu redor uma série de qualidades que, em certo quadro histórico, passa a operar como referência do ideal humano. É nesse sentido que Ariès identifica, em *Siegfried*, de Wagner, a primeira forma nítida do adolescente moderno: sua música reuniria pureza passageira, força física, contato com a natureza, espontaneidade e gosto pela vida, traços que fariam do adolescente o herói do século XX (ARIÈS, 1981, p. 22). Num primeiro momento, contudo, essa figura permaneceu circunscrita ao plano estético, sem ainda alcançar maior generalização social. Somente com a guerra de 1914 ela ganha densidade coletiva: os soldados da frente de batalha passam a se definir em contraste com as gerações mais velhas, resguardadas na retaguarda, e a percepção da juventude deixa de se limitar a personagens singulares para integrar uma experiência compartilhada (ARIÈS, 1981, p. 22). Dessa transformação decorre o deslocamento indicado pelo historiador: “passamos de uma época sem adolescência a uma época em que a adolescência é a idade favorita”, condição da qual se busca aproximar-se o mais cedo possível e na qual se deseja permanecer o máximo de tempo (ARIÈS, 1981, p. 23). O que antes aparecia apenas como passagem entre momentos da vida passa, então, a ocupar a posição mais valorizada do curso biográfico. Essa figura, produzida historicamente e ligada à espontaneidade, ao vigor do corpo e a uma pureza transitória, coincide, por sua vez, com o pressuposto dos dispositivos normativos, que definem o adolescente ao mesmo tempo como sujeito de direitos e como objeto de intervenção. Daí que a leitura genealógica proposta por Ariès conduza a uma pergunta decisiva: de qual adolescente se está falando e desde quando ele existe sob esse nome?

Retomando o ponto: a adolescência, quando pensada como categoria dotada de autonomia, não corresponde a um fato natural; trata-se, antes, de uma construção histórica e, como tal, sua emergência depende de uma temporalidade própria e de uma configuração determinada. Ariès sustenta que “a cada época corresponderiam uma idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana” (ARIÈS, 1981, p. 25). Desse modo, se no século XVII a juventude ocupou a posição de idade paradigmática, e se no século XIX esse posto coube à infância, no século XX foi a adolescência que passou a desempenhar essa função. Tomar uma idade como exemplar quer dizer fazer dela o centro em torno do qual se ordena um feixe de atributos que, em certa época, opera como padrão do humano ideal. De acordo com Ariès, o primeiro tipo moderno de adolescente foi o *Siegfried* de Wagner: na música se exprimia a ligação entre pureza passageira, força física, vizinhança com a natureza, espontaneidade e gosto de viver, qualidades que converteriam o adolescente no herói do século XX (ARIÈS, 1981, p. 22). Essa figura, porém, permaneceu por algum tempo circunscrita ao registro estético, já que ainda lhe faltava uma experiência coletiva capaz de lhe dar maior extensão. Foi a guerra de 1914 que a converteu em fato social: os soldados da frente se contrapuseram, em massa, às gerações mais velhas localizadas na retaguarda, e a consciência de juventude deixou de ser atributo de personagens isolados para se tornar parte de uma vivência comum (ARIÈS, 1981, p. 22). É desse processo que deriva o deslocamento formulado pelo historiador: “passamos de uma época sem adolescência a uma época em que a adolescência é a idade favorita”, condição à qual se pretende chegar cada vez mais cedo e na qual se deseja permanecer pelo maior tempo possível (ARIÈS, 1981, p. 23). Aquilo que antes se via apenas como momento de transição — a infância abandonada sem memória, o *puer* ainda indistinto do *adolescens* — converteu-se no ponto mais desejável do percurso. E, porque essa figura, produzida historicamente e ligada à espontaneidade, ao vigor do corpo e a uma pureza transitória, coincide com o pressuposto dos dispositivos normativos do presente, que fazem do adolescente ao mesmo tempo sujeito de direitos e alvo privilegiado de intervenção, a genealogia proposta por Ariès obriga a recolocar o problema: de que adolescente se está falando e desde quando ele passou a existir para que pudesse receber esse nome?

3.3. APENAS UMA PALAVRAS

A pergunta com a qual Ariès encerra seu percurso, de qual adolescente, afinal, se fala, recebe em Bourdieu uma formulação de resposta que, em vez de resolver a dificuldade, a

desloca e a torna mais exigente. "O fato de se falar dos jovens como de uma unidade social, de um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e de se referir esses interesses a uma idade definida biologicamente, constitui já uma evidente manipulação" (BOURDIEU, 1983): a juventude não remete a um dado simplesmente encontrado pelo conceito; ela se apresenta, antes, como produto de uma operação ficcional, e o que tal ficção recobre revela mais do que o próprio nome sob o qual a designa. A reconstrução histórica proposta por Ariès, da relativa pouca diferenciação entre puer e adolescens até a elevação do herói juvenil no século XX, chega ao ponto em que a categoria se afirma sob a aparência da naturalidade. É essa aparência, precisamente, que Bourdieu desfaz: "a idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável" (BOURDIEU, 1983), e, assim, a demarcação etária deixa de valer como mero reconhecimento de diferença prévia e passa a ser entendida como resultado de uma luta, "em todas as sociedades uma parada em jogo de luta" (BOURDIEU, 1983), cujo efeito está em instituir uma ordem que se impõe aos indivíduos sob a forma de posição a ocupar.

Desse modo, o adolescente não vem antes da separação que o nomeia; ele é engendrado por ela. A consequência mais forte dessa formulação não consiste em recusar a existência da adolescência, e sim em indicar que a unidade à qual o termo pretende remeter é, nos termos de Bourdieu, "um formidável abuso de linguagem" que subsume "no mesmo conceito universos sociais que praticamente nada têm em comum" (BOURDIEU, 1983). Há, pelo menos, duas juventudes, e a distância entre ambas não é apenas de grau, mas de constituição. Em um extremo, a adolescência aparece na forma de moratória, de "irresponsabilidade provisória" (BOURDIEU, 1983) viabilizada por determinada posição de classe, enquanto o tempo de espera pode ser mantido; em outro, impõe-se a entrada precoce no universo adulto do trabalho, da sobrevivência ou da violência, para aqueles diante dos quais essa moratória não se oferece na condição de possibilidade efetiva.

Essa operação classificatória encontra uma analogia controlada, em outro domínio, na análise de Mazon sobre a reemergência do TDAH e a centralidade adquirida pelo DSM-III na psiquiatria infantil. Não se trata de afirmar que idade e diagnóstico sejam classificações equivalentes, mas de observar que ambas dependem de critérios estabilizados, saberes autorizados, instituições de validação e procedimentos capazes de tornar certos sujeitos legíveis. A nosologia diagnóstica também se organiza historicamente, ao deslocar a psiquiatria de uma interpretação fundada na história de vida para uma forma de classificação

baseada em critérios descritivos, escalas e padronizações (MAZON, 2020, p. 115, 121, 125, 128). O diagnóstico, nesse quadro, não é simples efeito do mercado farmacêutico, mas tampouco é apenas nome neutro de uma realidade anterior: ele se constitui no cruzamento entre psiquiatria, manuais, pesquisa, indústria, escola e administração da saúde. Assim como a idade pode operar como recorte institucional da população, a categoria diagnóstica pode converter condutas infantis em sinais comparáveis. A força de uma classificação, portanto, não está apenas em nomear uma realidade anterior, mas em organizar os modos pelos quais certos sujeitos se tornam visíveis, comparáveis e passíveis de intervenção.

Depois de Bourdieu, a crítica à juventude como categoria aparentemente evidente pode ser deslocada, com cautela, para os dispositivos contemporâneos de saúde. Ao examinar os embates em torno do TDAH na saúde mental infantil, Da Silva Mazon mostra que a criança diagnosticável não aparece apenas como destinatária abstrata de proteção, mas como ponto de disputa entre discursos médicos, políticas públicas, associações de pacientes, indústria farmacêutica e práticas institucionais de reconhecimento (DA SILVA MAZON, 2024). Não se trata de equiparar o TDAH à adolescência, nem de afirmar que todo diagnóstico seja captura ou falsificação. O que interessa é o modo como uma categoria técnica pode organizar, ao mesmo tempo, acesso a direitos, possibilidades de cuidado e modalidades de intervenção. A tensão entre subdiagnóstico e sobrediagnóstico condensa essa ambivalência: de um lado, a denúncia da medicalização, que reduziria o sofrimento a transtornos individuais; de outro, a reivindicação do diagnóstico e do tratamento como expressão do direito à saúde. Esse deslocamento ajuda a precisar o problema que o protocolo recoloca em outro domínio: crianças e jovens não são apenas protegidos por normas, mas tornados inteligíveis por classificações. Mais do que saber se o jovem tem ou não acesso a um direito, importa perguntar quais categorias, critérios e disputas o tornam inteligível como destinatário legítimo de intervenção.

Nessa perspectiva, o adolescente que os documentos examinados neste capítulo produzem como figura homogênea, apto à incidência da norma desde os quinze anos, referido segundo os mesmos parâmetros comportamentais de risco aplicados à população adulta e tido por autônomo desde que demonstre compreensão, pressupõe exatamente o "grupo constituído" que Bourdieu identifica como ficção: uma unidade que apaga diferenças cuja consideração exigiria, no plano normativo, diferenciação que o protocolo não realiza.

4. PCDT, O DOCUMENTO

Quando se toma o PCDT a partir da formulação proposta por Lindsay Prior, ele já não pode ser visto como mero suporte de informação clínica a respeito da PrEP; passa, antes, a ser compreendido como dispositivo documental, isto é, como uma composição heterogênea na qual se conectam mandato jurídico, instâncias administrativas, evidência científica e julgamento técnico. Sua operação, nesse sentido, não se reduz a registrar um determinado estado do saber. O que ele faz, de modo propriamente normativo, é ordenar as condições em que a profilaxia pré-exposição se torna concebível, passível de recomendação e suscetível de implementação no âmbito de uma política pública.

A ideia de *author-function*, mobilizada por Prior (2003, p. 11-12), permite deslocar a questão da autoria do protocolo para além da figura de um autor individual, reconduzindo-a a uma função distribuída. O texto, assim, não procede de uma intenção técnica singular; ele se ancora num mandato estatal — inscrito no Decreto n.º 7.508/2011 — e se distribui entre o Dathi, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o Comitê Técnico e as instâncias de validação da Conitec (BRASIL, 2011; BRASIL, 2025). Esse caráter distribuído da autoria é decisivo, porque o documento não atua somente como canal de comunicação entre especialistas e serviços: nele se condensam competências, hierarquias, procedimentos de validação e modalidades de autoridade que viabilizam sua circulação como protocolo oficial.

Nessa perspectiva, o PCDT aparece, ao mesmo tempo, como texto, como instrumento e como prática condensada. Ele fixa uma linguagem compartilhada, circunscreve objetos de intervenção e dispõe uma cadeia decisória que percorre a formulação técnico-administrativa, a clínica, a dispensação e o acompanhamento. O capítulo segue essa operação em quatro momentos: no primeiro, investiga-se como o protocolo reinscreve sexualidade, vida e população em uma gramática da vulnerabilidade; no segundo, examina-se a racionalidade securitária que torna as exposições comparáveis e elegíveis; no terceiro, interroga-se o regime de verdade em que evidência, consenso e decisão se articulam; no último, mostra-se como a racionalidade populacional retorna ao indivíduo na figura do sujeito aderente, tornando visíveis, também, os limites do dispositivo.

4.1. SEXUALIDADE, VIDA E POPULAÇÃO

Se o PCDT for tomado como um dispositivo documental, a questão central já não consiste apenas em indagar quem o redige ou em nome de qual mandato, mas em perguntar

que realidade ele contribui para constituir. Esse deslocamento está longe de ser meramente retórico. Na quarta parte de *A vontade de saber*, Foucault rejeita a ideia de sexualidade como dado natural posteriormente descrito por um discurso e a concebe como dispositivo, isto é, como uma configuração histórica de saber e poder que produz aquilo mesmo de que trata, ao fazê-lo aparecer, ordenar e governar (FOUCAULT, 1988). Sob essa perspectiva, o protocolo não se reduz a um texto acerca de um medicamento; ele integra esse dispositivo, pondo em relação corpo, sexualidade, risco, espécie e população. A proposição que orienta esta subseção é, portanto, a de que o PCDT não reconduz o risco a uma identidade, embora tampouco abra mão de torná-lo inteligível: em vez de assumir o “grupo” como essência, institui a “vulnerabilidade acrescida” como categoria na qual se articulam determinantes sociais, práticas sexuais e exposição provável.

Esse distanciamento diante de uma leitura identitária do risco aparece de modo explícito no próprio texto. Quando trata dos contextos de vulnerabilidade ampliada, o PCDT afirma que “o simples pertencimento a um dos segmentos populacionais-chave que apresentam maior prevalência de HIV em relação à população geral [...] não é suficiente para caracterizar indivíduos em situação de maior vulnerabilidade ao HIV” (BRASIL, 2025, p. 18). Em seguida, o documento desloca novamente a análise para os determinantes sociais da exposição, ao assinalar que “a prevalência de HIV é também fortemente determinada por fatores sociais, como a vivência de situações de homofobia, transfobia, racismo, sexismo e outras formas de violência e vulnerabilização social” (BRASIL, 2025, p. 18).

Vê-se, assim, uma recusa clara de qualquer automatismo por meio do qual uma identidade viria a equivaler, sem mediações, a risco. Isso, contudo, não significa que a classificação deixe de operar; significa, antes, que o seu princípio passa por redefinição. O protocolo produz uma transformação interna no dispositivo da sexualidade, e não um afastamento dele: mantém-se a função que torna a sexualidade legível e administrável, mas modifica-se o critério classificatório. O risco já não se fixa apenas na identidade populacional e passa a apoiar-se numa articulação entre pertencimentos, práticas sexuais, trajetórias e condições sociais de exposição.

É precisamente essa composição que a noção de vulnerabilidade acrescida procura enlaçar. No interior de uma única categoria, o texto articula ordens heterogêneas: de um lado, determinantes sociais inscritos no plano da desigualdade estrutural; de outro, práticas sexuais situadas no plano da conduta; além disso, a exposição provável, situada no plano do cálculo

(BRASIL, 2025). Assim, a vulnerabilidade funciona como ponto de condensação em que essas linhas se encontram, ou seja, como operador que traduz um campo social e biográfico em um campo clinicamente legível.

Não se está diante de uma simples adição de fatores, mas de uma operação de tradução. Racismo e transfobia ingressam no protocolo não como objetos de intervenção em si mesmos, e sim na medida em que modulam a probabilidade de exposição e a continuidade do cuidado. A sexualidade comparece aqui exatamente no lugar em que Foucault a situa: como ponto de passagem particularmente denso das relações de poder, no qual práticas e desejos são reinscritos como sinais passíveis de administração.

Com isso, também se desloca o objeto de governo. Já não se trata apenas do indivíduo clínico tomado isoladamente, mas de uma população sexualmente exposta. A quinta parte de A vontade de saber oferece o ponto de apoio mais preciso para compreender esse movimento: a passagem de um poder soberano, exercido como direito de morte e de subtração, para um poder que investe sobre a vida e atua por regulações de conjunto, convertendo o sexo e sua fecundidade em objeto de gestão — “o sexo e sua fecundidade devem ser administrados”, escreve Foucault ao tratar da administração estatal dos nascimentos e das sobrevivências (FOUCAULT, 1988). É ainda nesse ponto que ele descreve a generalização do dispositivo, por meio da qual o corpo social inteiro foi provido de um “corpo sexual”. É a esse corpo que o PCDT se dirige: não ao indivíduo isolado, nem a uma identidade, mas a uma população apreendida segundo sua exposição sexual, em consonância com o que Foucault designa como passagem da simbólica do sangue para uma analítica da sexualidade. O HIV deixa, então, de ser governado sob a forma da interdição e passa a ser administrado como problema relativo à vida sexual do conjunto.

Seria, no entanto, apressado concluir daí que o indivíduo se dissolveria nessa população. Pois o dispositivo da sexualidade opera, desde a formulação foucaultiana, por intermédio do indivíduo: pela incitação ao discurso, pela extração da verdade do sujeito, por uma *scientia sexualis* que leva cada um a falar de si para tornar-se legível (FOUCAULT, 1988). No protocolo, a vulnerabilidade acrescida não é medida no plano abstrato da população, mas no encontro clínico, caso por caso, mediante a leitura individualizada de uma trajetória sob a chave do risco. A população sexualmente exposta só existe, no texto, como série dessas leituras singulares: ela é efeito de conjunto de avaliações que continuam a ser feitas uma a uma. O objeto populacional, portanto, é apreendido por mediações

individualizadas, e sua consistência reside justamente nessa articulação, não em qualquer supressão dela.

Pode-se, assim, precisar aquilo que o protocolo faz existir. O PCDT desloca a inteligibilidade do HIV das identidades fixas para uma gramática da vulnerabilidade, sem por isso abandonar a produção de categorias governáveis; ao contrário, é por meio dessa gramática que tais categorias são produzidas. Desse modo, constitui como objeto de governo não apenas sujeitos clínicos, mas uma população sexualmente exposta, isto é, um campo de visibilidade e de intervenção sobre a sexualidade e sobre a vida, sempre, porém, apreendido por trajetórias individualizadas. Constituída essa população, importa examinar por qual técnica ela é comparada, distribuída e tornada administrável.

4.2. SEGURANÇA, CIRCULAÇÃO E ELEGIBILIDADE

A população sexualmente exposta, uma vez constituída como objeto de governo, não se rege por si mesma. Requer-se, antes, uma técnica capaz de tornar comparáveis práticas, corpos, trajetórias e formas de exposição; e é justamente nesse deslocamento que a elegibilidade adquire centralidade. Para tornar mais precisa a racionalidade que a sustenta, convém passar de A vontade de saber ao curso de 1978, no qual Foucault distingue três modalidades de exercício do poder — o sistema jurídico, os mecanismos disciplinares e os dispositivos de segurança — e sublinha que não há entre elas uma sucessão, mas uma coexistência acompanhada de recomposições (FOUCAULT, 2008a). É essa articulação simultânea, mais do que a troca de um regime por outro, que o protocolo permite apreender.

O PCDT apresenta, de fato, uma feição jurídica: existem requisitos cuja ausência impede o acesso, assim como um campo de indicação que discrimina entre aqueles que podem iniciar e aqueles que não podem. Há, igualmente, uma dimensão disciplinar, na medida em que se prescreve a conduta do corpo individual quanto à posologia, ao retorno regular e ao controle por exames. Ainda assim, o princípio que estrutura o conjunto não se reduz nem à proibição nem ao adestramento. Na aula de 11 de janeiro de 1978, a segurança é definida a partir de sua atuação sobre um meio em que circulam séries abertas de acontecimentos, administradas probabilisticamente, sem que o risco seja abolido (FOUCAULT, 2008a). Transposto esse ponto para o protocolo, a questão relevante já não é se certa prática deve ser admitida ou interdita, mas quais exposições são prováveis, em que frequência surgem, em que séries se inscrevem e a partir de qual limiar a intervenção se torna justificável.

Essa distinção é fundamental. A aula de 25 de janeiro a explicita com maior rigor: enquanto a normação disciplinar parte de uma norma prescritiva e distribui os indivíduos entre conformes e desviantes, a normalização securitária toma como ponto de partida normalidades diferenciais, reconhece curvas mais ou menos favoráveis e faz com que operem umas sobre as outras (FOUCAULT, 2008a). O documento não estabelece previamente uma norma de conduta sexual para, em seguida, localizar o desvio; ele assume a distribuição das práticas como dado e, sobre essa base, modula o acesso.

É nesse plano que o quadro de probabilidade por exposição revela sua gramática de governo. A análise da varíola, na aula de 25 de janeiro, descreve a substituição da velha doença reinante pelas noções de caso, risco, perigo e série, noções que tornam possível tratar a população como campo contínuo de probabilidades (FOUCAULT, 2008a, p. 97-103). O quadro do PCDT repõe, em escala clínica, esse mesmo movimento: cada prática é inscrita como caso em uma série, e a exposição aparece como variável suscetível de administração. Já não se trata da exposição como acontecimento apenas singular; ela passa a integrar uma série calculável, e é essa série — não cada ato isoladamente considerado — que se converte em objeto de cálculo e de intervenção.

Sob esse ângulo, a elegibilidade já não pode ser entendida apenas como porta administrativa. Ao deslocar a vulnerabilidade do pertencimento a grupos-chave para práticas, parcerias e determinantes sociais, o protocolo afasta o automatismo que converte identidade em risco; ao mesmo tempo, contudo, singulariza a avaliação e entrega ao encontro clínico a tarefa de ler a biografia sob a chave do risco (BRASIL, 2025). A aula de 25 de janeiro descreve a passagem do sujeito de direito — figura jurídica estável — à população apreendida como série de casos variáveis, ao passo que a aula de 1º de fevereiro define a governamentalidade como racionalidade cujo alvo principal é a população, cuja forma de saber é a economia política e cujo instrumento técnico são os dispositivos de segurança (FOUCAULT, 2008a, p. 155-159). A avaliação individualizada prevista pelo protocolo funciona segundo essa lógica: não se trata de verificar a pertinência a uma categoria, mas de compor um perfil de exposições, parcerias e circunstâncias cujo sentido só se produz sobre o fundo da série populacional. A fronteira de entrada é probabilística porque o objeto que ela circunscreve é, ele mesmo, uma distribuição de risco, e não um traço identitário; o “contexto de vulnerabilidade acrescida” funciona como operador plástico dessa abertura (BRASIL, 2025).

Os recortes binários não invalidam essa leitura; ao contrário, tornam visível a permanência da lei e da disciplina no interior do dispositivo. O teste reagente exclui a profilaxia sem gradações, porque, nesse caso, o que está em causa já não é a probabilidade de uma infecção futura, mas o risco de resistência sob um esquema insuficiente: um sim ou um não, sem série e sem composição. Já os limiares de idade, peso e função renal operam como cortes objetivos inscritos sobre o corpo, mais próximos da forma jurídica do interdito e do limiar disciplinar do que da modulação securitária (BRASIL, 2025). Não se está, porém, diante de um retorno da lei contra a segurança; trata-se precisamente da composição prevista no curso, que recusa qualquer linearidade sucessiva entre os mecanismos.

A modalidade sob demanda torna mais nítido esse cruzamento, pois vincula a profilaxia ao grau de previsibilidade das práticas sexuais. No PCDT, ela aparece como PrEP oral "orientada para eventos" — também designada ED-PrEP —, segundo o esquema 2 + 1 + 1: dois comprimidos entre 2 e 24 horas antes da relação sexual, um comprimido 24 horas após a dose inicial e mais um 24 horas depois da segunda dose (BRASIL, 2025, p. 39). Sua indicação, porém, não é ampla nem irrestrita. O próprio documento estabelece que "os grupos elegíveis para PrEP sob demanda são: homens cis heterossexuais, bissexuais, gays e outros homens cis que fazem sexo com homens, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer e travestis e mulheres transexuais que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol" (BRASIL, 2025, p. 39), com a exigência adicional de que tenham relações sexuais em frequência menor que duas vezes por semana e possam programar o uso do esquema com pelo menos duas horas de antecedência (BRASIL, 2025, p. 39).

Essa delimitação mostra que a modalidade sob demanda não deve ser descrita como destinada a "certos corpos", e sim como recomendação circunscrita por critérios de população, frequência sexual, previsibilidade e tipo de prática. O documento fixa ainda um limite decisivo: "os estudos de PrEP sob demanda não apresentam evidências de proteção para relações sexuais neovaginais receptivas"; por isso a indicação se volta para relações anais, insertivas ou receptivas, e para relações vaginais insertivas (BRASIL, 2025, p. 40). A recomendação se funda, assim, menos na identidade de quem usa o método do que na articulação entre evidência disponível, forma de exposição, possibilidade de planejamento e regime de uso do medicamento.

Nesse arranjo, a população não é apenas o grupo-alvo abstrato a que a política se dirige: é a superfície técnica sobre a qual exposições se medem, comparam e ordenam, e sem a qual a

escala de risco perderia inteligibilidade. A elegibilidade, por sua vez, não nomeia uma porta que se abre ou se fecha, mas o ponto em que práticas, corpos, exames e probabilidades se traduzem em decisão de governo. Sua consistência não vem do predomínio de um mecanismo sobre os outros, mas da composição entre a lei que veta, a disciplina que prescreve e a segurança que modula — composição em que a zona ampla da normalização e os poucos cortes técnicos estreitos pertencem a um mesmo modo de governo. Resta saber por meio de que procedimentos essa decisão se autoriza como verdadeira.

4.3. VERDADE, EVIDÊNCIA E DECISÃO

É útil tomar a seção “Busca da evidência e recomendações” a partir do movimento metodológico com que Foucault inaugura o curso de 1979. Na aula de 10 de janeiro, em vez de assumir universais — o Estado, a sociedade, a loucura — como matriz anterior de inteligibilidade, ele sugere partir de práticas determinadas e concretas, formulando a hipótese de que “os universais não existem” e indagando de que maneira certas realidades vêm a existir no interior de um regime de verdadeiro e falso (FOUCAULT, 2008b). Se essa inflexão for transportada, com a cautela necessária, para o protocolo, ela impede que a questão seja posta nos termos de saber se o PCDT apreende uma verdade previamente existente sobre o risco de infecção, e desloca o foco para os procedimentos mediante os quais ele constitui validade. A subseção dedicada à busca da evidência é, precisamente, o ponto em que esse processo pode ser observado: não como narrativa de um conhecimento simplesmente encontrado, e sim como exposição do aparato que estabelece o que contará como conhecimento pertinente. Nessa medida, pode-se afirmar que o protocolo não apenas mobiliza evidências, mas governa por meio de uma verdade produzida de forma metódica.

Esse aparato se dispõe em estratos que não se limitam a localizar a verdade, mas fixam as condições sob as quais algo pode ser enunciado como verdadeiro e recomendável. A questão clínica é previamente moldada pela forma PICO/PICOS², que determina população, intervenção, comparador e desfecho antes mesmo da busca; os descritores controlados —

² PICO/PICOS: estratégia metodológica usada para formular perguntas de pesquisa clínica. A sigla corresponde a população, intervenção, comparador, desfecho e, no caso de PICOS, tipo de estudo. No PCDT da PrEP, essa estrutura organiza a pergunta sobre a modalidade de PrEP sob demanda (BRASIL, 2025, p. 64-65).

DeCS³, MeSH⁴, Emtree⁵ — circunscrevem o vocabulário no qual a pesquisa se torna reproduzível e passível de auditoria; as bases indexadas recortam o universo do recuperável; a revisão sistemática condensa; o método GRADE⁶ hierarquiza a certeza da evidência; o consenso entre especialistas soluciona os conflitos que persistem; e a validação técnico-administrativa, seguida de consulta pública, fecha o circuito (BRASIL, 2025).

Dispostos nessa ordem, tais estratos dão a impressão de um procedimento puramente técnico, em que cada passo apenas prepara o seguinte. A rigor, porém, o dispositivo funciona menos como meio de revelar verdades já dadas do que como uma gramática que estabelece previamente o que pode valer como enunciado clínico legítimo. Antes mesmo de começar a busca, a própria interrogação já foi moldada pela estrutura PICO/PICOS, que reparte o problema clínico em população, intervenção, comparador e desfecho, e força o pesquisador a raciocinar no interior de uma matriz antecedente. Aquilo que se oferece como instrumento metodológico neutro é, em realidade, uma operação normativa: só as perguntas passíveis de tradução nesses termos recebem o estatuto do que pode ser investigado. Os descritores controlados prolongam essa mesma tarefa de demarcação, ao fixarem o léxico em que a investigação se torna reproduzível e auditável, submetendo cada termo a vocabulários padronizados que garantem que dois pesquisadores, em tempos distintos, reencontrem o mesmo objeto. A linguagem, então, deixa de ser apenas meio de expressão e passa a ser condição de existência: o que não pode ser nomeado dessa maneira simplesmente não entra no campo do visível.

Uma vez enunciada nesse vocabulário regulado, a pergunta se defronta com um universo que já lhe chega previamente recortado: as bases indexadas não reúnem tudo o que foi produzido, mas apenas aquilo que foi tido como recuperável, de sorte que os estudos

³ DeCS: Descritores em Ciências da Saúde. Trata-se de um vocabulário controlado utilizado para padronizar termos de busca em bases bibliográficas da área da saúde. No PCDT, aparece como parte da estratégia de busca da literatura científica (BRASIL, 2025, p. 65)

⁴ MeSH: Medical Subject Headings. É o vocabulário controlado utilizado pela base PubMed/MEDLINE para indexação e recuperação de artigos científicos. No PCDT, aparece articulado à estratégia de busca bibliográfica (BRASIL, 2025, p. 65).

⁵ Emtree: vocabulário controlado utilizado pela base EMBASE para indexação de estudos biomédicos e farmacológicos. No PCDT, aparece como um dos instrumentos empregados para estruturar a busca da literatura científica (BRASIL, 2025, p. 65).

⁶ GRADE: método de avaliação da certeza da evidência científica. A sigla corresponde a Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. No PCDT, o GRADE foi utilizado para graduar a qualidade do conjunto final de evidências, não sendo um exame clínico nem um critério individual de elegibilidade para PrEP (BRASIL, 2025, p. 67).

excluídos da indexação são, para todos os efeitos práticos, inexistentes. É sobre esse corpus delimitado que incide a revisão sistemática, cuja função consiste em condensar a dispersão dos resultados em um único enunciado sintético, reduzindo a multiplicidade dos achados a uma resultante comum. O método GRADE, por sua parte, não se restringe a reunir a evidência, mas a ordena hierarquicamente, atribuindo graus de certeza que convertem a heterogeneidade dos estudos em uma escala organizada de confiança. O que era múltiplo e, por vezes, contraditório vai assim sendo reduzido, pouco a pouco, a uma grandeza graduada, na qual cada evidência ocupa um lugar em uma hierarquia que já antecipa o seu peso na decisão final.

Quando essa hierarquia técnica da evidência não basta para desfazer as divergências, o consenso entre especialistas intervém como instância encarregada de resolver o restante do desacordo, introduzindo, nos intervalos do método, uma autoridade propriamente social que decide ali onde os números já não falam. O circuito se completa com a validação técnico-administrativa e, em seguida, com a consulta pública⁷, que conferem à recomendação a legitimidade institucional e procedimental sem a qual ela não se converteria em norma (BRASIL, 2025). Ao termo desse percurso, o que circula sob a forma de recomendação baseada em evidência não é o reflexo simples de uma realidade exterior, mas o produto de uma cadeia de operações que selecionou a pergunta, delimitou o vocabulário, restringiu as fontes, condensou os resultados, hierarquizou a certeza e arbitrou os conflitos, e em que cada etapa acrescenta uma camada de autoridade, fazendo o enunciado final aparecer, ao mesmo tempo, como verdadeiro e como recomendável.

Esse aparecer, porém, não coroa um percurso tão retilíneo quanto a sucessão das etapas faz supor. Nenhuma delas opera como filtro que isola uma verdade já depositada nos fatos; cada uma funciona, antes, como operador de veridicção, no sentido em que Foucault, na aula de 10 de janeiro, descreve a articulação entre uma série de práticas e um regime de verdade que inscreve no real aquilo que submete à demarcação do verdadeiro e do falso (FOUCAULT, 2008b). O “risco” e a “elegibilidade” não estão dados antes do aparato que os torna mensuráveis; é no percurso por ele que ambos se constituem.

⁷ A Consulta Pública nº 53/2024, para a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV, foi realizada entre os dias 30/08/2024 e 18/09/2024. Foram recebidas 15 contribuições, que podem ser verificadas em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/participacao-social/consultas-publicas/encerradas>.”

A aula de 17 de janeiro oferece, por sua vez, a imagem mais exata para dar nome a essa dinâmica. Foucault mostra que o mercado, que até então era um lugar de jurisdição — regido pelo preço justo e pela punição da fraude —, torna-se, em meados do século XVIII, lugar de veridicção: o espaço em que se forma um preço verdadeiro, que passa a funcionar como prova da ação governamental e diante do qual o governo aprende a limitar a si mesmo (FOUCAULT, 2008b). Empregada com o cuidado conceitual devido, essa chave permite ler todo o conjunto da evidência clínica como lugar de veridicção do protocolo: não a instância que prescreve por autoridade, mas aquela em que cada recomendação é posta à prova do verdadeiro e do falso. Nesse arranjo, o método GRADE surge como a forma técnica dessa autolimitação: o protocolo retém a força de suas próprias afirmações conforme o grau de certeza que o aparato autoriza, em vez de falar por uma autoridade indiferenciada. O critério em jogo passa a ser, então, menos o da legitimidade do que o do efeito e da utilidade, no registro em que Foucault, ainda na aula de 10 de janeiro, descreve a passagem de uma razão que pergunta por aquilo que a autoriza para uma razão que interroga aquilo que sua ação produz (FOUCAULT, 2008b).

Daí decorre uma consequência central: a autoridade do PCDT não vem apenas da presença do dado, mas também do trato explícito de suas lacunas. Quando os ensaios não cobrem certa população ou certa prática, o protocolo não se cala nem decide ao acaso; ele aciona a analogia, o consenso de especialistas e a consonância com diretrizes internacionais para conservar a decisão no interior da demarcação entre o verdadeiro e o falso, em lugar de deixá-la cair fora dela, no arbítrio. A força normativa depende, pois, tanto daquilo que o aparato demonstra quanto do modo regulado por que trata o que não pode demonstrar — e é esse modo, mais do que a simples cobertura empírica, que sustenta a recomendação.

Dois momentos do texto tornam isso especialmente visível. Ao recomendar a PrEP sob demanda com base em ensaios clínicos e em consenso técnico, ainda que esse esquema não esteja aprovado em bula, o protocolo opera com uma forma de uso off-label⁸. Isto é, trata-se de uma indicação que não coincide inteiramente com as condições formalmente registradas para o medicamento, mas que passa a ser sustentada por outro circuito de validação: revisão da evidência disponível, avaliação técnico-científica, ponderação de riscos e benefícios e

⁸ O uso off-label designa a utilização de um medicamento fora das condições expressamente aprovadas em bula, seja quanto à indicação, à população, à dose, ao regime de administração ou à forma de uso. Para uma discussão sociológica sobre os limites do uso racional de medicamentos e sobre as tensões que atravessam a circulação de psicotrópicos em contextos nos quais mercado, saber técnico e práticas terapêuticas se articulam, ver Mazon (2022).

formulação de uma recomendação pública. Assim, a autoridade da recomendação não deriva apenas da bula, mas do próprio aparato que organiza a diretriz clínica.

Do mesmo modo, ao declarar “razoável extrapolar” o risco para outras populações designadas do sexo masculino ao nascer, o documento estende por analogia uma evidência inicialmente produzida para homens que fazem sexo com homens e fixa seu limite no ponto em que essa analogia deixa de encontrar apoio empírico: o sexo neovaginal receptivo, excluído pela ausência de estudos específicos (BRASIL, 2025). Em nenhum desses casos há falha do regime de verdade. O que se observa são operações reguladas em seu interior, nas quais a decisão é tomada e, ao mesmo tempo, tem sua base explicitada e tornada inspecionável, diferindo, portanto, de uma decisão que oculta os fundamentos sobre os quais se apoia.

A consulta pública fecha esse circuito, sem por isso eliminar a assimetria que o organiza. As contribuições sociais passam a compor a cena de validação, mas não substituem o polo técnico-administrativo que produz o texto e fixa o estatuto das recomendações. A distância entre a densidade metodológica do protocolo e o número reduzido de manifestações públicas pode ser lida, assim, não como mera insuficiência de participação, mas como traço da própria vida social do documento: o PCDT circula como texto aberto à contribuição e, ao mesmo tempo, como instrumento cuja autoridade já se acha fortemente estruturada por procedimentos técnicos, administrativos e científicos (BRASIL, 2025; PRIOR, 2003). A participação ingressa, portanto, numa forma documental que a precede e que estabelece os termos em que ela poderá contar.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso do Truvada® como profilaxia pré-exposição para adolescentes a partir de 15 anos em abril de 2021, ampliando uma indicação que até então se restringia a adultos.⁹ Os registros administrativos da própria agência mostram que o pedido de ampliação havia sido protocolado em setembro de 2019 — quase dois anos antes do deferimento e antes de qualquer resultado publicado pelo estudo

⁹ ANVISA. *TRUVADA® (entricitabina + fumarato de tenofovir desoproxila): nova indicação*. Brasília, 12 abr. 2021. Resolução Específica nº 1.468, publicada no DOU nº 67, de 12/04/2021. Disponível: gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/truvada-r-entricitabina-fumarato-de-tenofovir-desoproxila-nova-indicacao.

PrEP1519, que à época ainda estava em fase de recrutamento.¹⁰ A petição foi processada sob regime de análise prioritária, mecanismo previsto na regulação brasileira para pedidos de extensão de uso a populações pediátricas.¹¹ A decisão da Anvisa não incorpora o medicamento ao sistema público de saúde — essa função é da Conitec —, mas tem efeito regulatório decisivo: ao alterar formalmente a bula do produto para uso pediátrico em PrEP, remove a principal restrição técnica que impedia a Conitec de deliberar sobre a extensão desde 2017, quando a comissão havia recusado a incorporação para adolescentes por ausência de evidências suficientes para essa faixa etária. A incorporação no SUS viria em 2022.¹²

Não está em questão, por conseguinte, aferir se o PCDT acerta ou erra ao decidir sob incerteza. O que a análise põe em evidência é o modo pelo qual ele produz legitimidade decisória: por meio de um regime de verdade tecnicamente organizado, no qual evidência, analogia, consenso e validação institucional não se contrapõem, mas operam em articulação, cada qual suprimindo o que falta aos demais. A evidência fornece o apoio demonstrável; a analogia o prolonga onde esse apoio não alcança; o consenso decide onde a demonstração não basta; a validação institucional confere ao conjunto a forma de recomendação de Estado. Nesse entrelaçamento, o protocolo governa por uma verdade produzida metodicamente. Para efetivar-se, porém, essa verdade ainda requer um operador individual: alguém que converta a recomendação em rotina, que antecipe exposições e que sustente a profilaxia como prática contínua.

4.4. SUJEITO ADERENTE E LIMITES DO DISPOSITIVO

Ao término, permanece uma indagação que o trajeto analítico do capítulo não resolveu inteiramente: se o protocolo se organiza por séries, probabilidades e curvas, qual é, então, o lugar do indivíduo? A resposta não deve ser procurada numa exterioridade excepcional, mas no interior da própria configuração do biopoder. Na quinta parte de *A vontade de saber*, Foucault apresenta um poder voltado para a vida que se distribui em dois polos conexos — de um lado, uma anatomopolítica do corpo, orientada para disciplinar e maximizar as forças individuais; de outro, uma biopolítica da população, voltada para regular nascimentos,

¹⁰ ANVISA. Portal de Situação de Documentos. Expediente nº 2183962/19-0, Processo nº 25351.036639/2019-92. Assunto: 11119 — RDC 73/2016 — NOVO — Ampliação de uso. Consultado em 15/06/2026.

¹¹ ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 204, de 27 de dezembro de 2017. Art. 4º, II. Brasília: Anvisa, 2017. Revogada pela RDC nº 1.001/2025, que manteve o mesmo critério.

¹² BRASIL. Ministério da Saúde. Conitec. *Relatório de Recomendação nº 739*. Brasília, 2022. Portaria SCTIE/MS nº 90, de 25 de agosto de 2022.

sobrevivência e processos coletivos —, mostrando ainda que a sexualidade constitui precisamente a articulação entre ambos (FOUCAULT, 1988). É esse nexo que a profilaxia pré-exposição torna novamente legível: ela opera sobre uma população de exposições calculáveis e, ao mesmo tempo, normatiza um corpo. A racionalidade populacional, assim, não suprime o indivíduo; ela reaparece nele como adesão, acompanhamento, autovigilância e responsabilização clínica. Desse modo, pode-se reafirmar a tese final do capítulo: o PCDT converte a infecção por HIV em questão de governamentalidade, e seu limite não consiste em não perceber o social, mas em traduzi-lo de outro modo.

Importa assinalar, antes de tudo, aquilo que o documento efetivamente reconhece. No plano diagnóstico, o PCDT procede com minúcia e explicita determinantes sociais: desloca a vulnerabilidade do mero pertencimento a grupos-chave para o âmbito das práticas, das parcerias e das condições estruturais, e identifica estigma, discriminação, racismo, transfobia e barreiras de acesso como fatores produtores de desigualdade tanto na exposição quanto no cuidado (BRASIL, 2025). Não se está diante, portanto, de um texto indiferente à estrutura; ao contrário, a desigualdade é incorporada ao próprio léxico do risco. O problema analítico, assim, não é apontar uma falta, e sim examinar o destino dado, pelo protocolo, àquilo mesmo que ele admite.

Esse reconhecimento, contudo, não altera o núcleo operativo do dispositivo. A aula de 4 de abril de 1979 oferece uma chave decisiva para compreender isso. Nela, Foucault indica que a arte liberal de governar não absorve o indivíduo no interior da população: o homo *œconomicus*, enquanto sujeito de interesse, resiste em princípio à apreensão totalizante do soberano, razão pela qual o governo necessita de um campo correlato no qual sujeitos concretos se tornem governáveis — a sociedade civil, que não antecede naturalmente o governo, mas se constitui como realidade de transação, correlata de uma tecnologia governamental, da qual homo *œconomicus* e sociedade civil são componentes inseparáveis (FOUCAULT, 2008b). Se essa formulação for deslocada com o devido cuidado, a consequência é clara: toda racionalidade que governa por meio do cálculo de conjuntos requer uma superfície individual sobre a qual possa incidir. No protocolo, essa superfície toma a forma do sujeito encarregado de administrar a própria conduta: o cálculo populacional, para produzir efeitos, retorna à escala individual da prevenção.

É nesse retorno, e nos efeitos que ele organiza, que adesão, acompanhamento, planejamento do uso e reinserção no serviço deixam de aparecer apenas como prescrições clínicas e passam

também a operar como mecanismos de condução de si. A adesão faz da proteção uma prática contínua do próprio usuário; a exigência de planejamento temporal, na modalidade sob demanda, pressupõe que ele possa antecipar situações de exposição; o retorno periódico, por sua vez, institui uma rotina de acompanhamento que é reconhecida e formalizada pelo protocolo. O PCDT estabelece que a dispensação inicial da PrEP se dê por 30 dias e que, uma vez verificada a adesão da pessoa à estratégia, “o seguimento clínico será quadrimestral (a cada 120 dias)” (BRASIL, 2025, p. 47).

Essa periodicidade, no entanto, não se confunde com a simples reposição do medicamento. Em cada consulta, devem ser examinados os sinais e sintomas de infecção aguda, os efeitos adversos, a adesão, as exposições de risco e a continuidade da profilaxia; além disso, o teste para HIV passa a ser obrigatório em toda consulta, com realização depois de um mês do início da PrEP e, depois, de modo quadrimestral (BRASIL, 2025, p. 47-48). O acompanhamento faz, assim, com que a prevenção se disponha como uma sequência regular de retornos, exames, relatos e reavaliações, por meio da qual o usuário permanece vinculado ao serviço e à atualização contínua do próprio risco. Recompõe-se, desse modo, uma das estruturas descritas em *A vontade de saber*: aquela em que o indivíduo é levado a relacionar-se consigo mesmo como objeto de saber, atenção e administração cotidiana de sua conduta (FOUCAULT, 1988).

Daí resulta uma formulação mais precisa do limite. O social não é apagado no PCDT; ele é retraduzido tecnicamente. A desigualdade, reconhecida no texto como estrutural, retorna como variável de risco e como marcador de descontinuidade; o estigma, nomeado como problema institucional, é tratado no plano da relação clínica; o determinante social converte-se em critério de elegibilidade, permanência e adesão. Como observa Prior, classificar significa produzir visibilidade e, com isso, também administrabilidade: aquilo que ingressa na grade de inteligibilidade já ingressa como variável passível de manejo (PRIOR, 2003). O dispositivo, portanto, não desconhece a estrutura; ele a reinscreve numa forma sobre a qual seus instrumentos podem atuar, isto é, a forma da conduta individual monitorada.

Essa seletividade se manifesta igualmente naquilo que o protocolo apreende de maneira limitada ou simplificada. A sexualidade é admitida e, ao mesmo tempo, recodificada em indicadores de risco; a autonomia é enunciada, mas circunscrita pela elegibilidade e pela adesão; o território aparece de forma rarefeita; a experiência vivida comparece sobretudo quando pode ser convertida em sinal clínico, barreira de acesso ou marcador de continuidade.

Um de seus silêncios, aliás, diz menos respeito ao documento tomado isoladamente do que à rede de evidências na qual ele se insere, pois a limitação da modalidade sob demanda a certos corpos herda o caráter centrado no masculino próprio do cânone de ensaios. O limite do dispositivo, portanto, não está em nada enxergar, mas em enxergar segundo uma grade que converte desigualdades, práticas e trajetórias em variáveis governáveis.

Em síntese, o argumento do capítulo pode ser condensado do seguinte modo: o PCDT faz da infecção por HIV um problema de governamentalidade não por recurso impreciso ao termo, mas porque articula, num mesmo documento, o mandato estatal que lhe confere autoridade, o saber especializado que o legitima, a classificação de risco que lhe dá estrutura, o cálculo probabilístico que o orienta e o autogoverno que lhe assegura efetivação. Reconhece o social e, no mesmo movimento, reconverte-o em variável governável, reinscrevendo a vulnerabilidade numa gramática de monitoramento, adesão e continuidade do cuidado. Tudo isso, porém, foi examinado no plano da página — isto é, no protocolo como dispositivo escrito. Como Prior insiste, o texto constitui apenas uma das dimensões de sua vida social; seu funcionamento efetivo só pode ser apreendido

5. O MEDICAMENTO

O que vinha sendo descrito no plano das práticas e dos discursos encontra, neste ponto, outro registro de análise: o do próprio fármaco. Tomá-lo como objeto não significa restringir a investigação à química das substâncias ou à cronologia dos ensaios clínicos, mas interrogar a racionalidade que aí se forma e se sedimenta. A hipótese que organiza as páginas seguintes é a de que o antirretroviral, antes de comparecer como recurso de prevenção, constituiu o terreno em que se desenhou a lógica que a PrEP mais tarde herdaria: a de intervir no presente sobre um adoecimento que talvez nem chegue a se efetivar. Seguindo o trajeto que vai do AZT à terapia combinada, busca-se mostrar como o medicamento foi deixando de responder a uma doença já instalada para operar como técnica de contenção, de antecipação e de acompanhamento continuado, e como, nesse mesmo movimento, a vida molecular dos corpos foi sendo inscrita, a um só tempo, em uma política e em uma economia. Menos do que a história de uma droga em particular, é desse deslocamento que aqui se trata.

5.1. AZT

A formação do dispositivo da aids não se deu apenas no espaço público do temor e das práticas de prevenção. Em paralelo, tomou corpo um trabalho no interior dos laboratórios. Epstein (1996, p. 181-184) assinala que a adoção da hipótese retroviral recompôs a maneira pela qual a doença passou a ser tornada inteligível no terreno terapêutico: se, num primeiro momento, o esforço incidia sobretudo sobre o tratamento das infecções oportunistas ligadas à imunossupressão, mais tarde a atenção se deslocou para o próprio vírus. O ponto decisivo, aqui, não reside no detalhe da substância, mas no nível em que a doença pode ser pensada e governada. É esse o processo de molecularização de que trata Rose (2007, p. 11-16): ao fazer do vírus um alvo, a aids é inscrita num quadro molecular em que a vida se torna disponível à intervenção, ao cálculo e à política. O AZT condensou de modo particularmente nítido esse movimento. Substância reutilizada — concebida de início contra o câncer, em seguida deixada de lado e, depois, reativada contra o retrovírus —, ela evidencia a mobilidade que a molecularização confere às intervenções biomédicas, passíveis de ser reinscritas em novos alvos, usos e circuitos terapêuticos (Epstein, 1996, p. 192-194). Sua introdução, contudo, não assumiu a forma de uma cura, mas a de uma técnica de contenção e de gestão, uma tecnologia de otimização voltada a agir, no presente, sobre o futuro da doença (Epstein, 1996, p. 183-184; Rose, 2007, p. 16). Nesses termos, converteu-se ao mesmo tempo em objeto biomédico e em objeto político: promessa terapêutica, matéria de ensaio clínico e questão de acesso aos corpos.

No entanto, um fármaco não chega aos corpos apenas em virtude da consistência que possa exibir no plano científico. Entre a substância produzida e delimitada no laboratório e a pessoa que a toma, interpõe-se um conjunto institucional inteiro: a autoridade regulatória, os organismos públicos de pesquisa, os protocolos, os ensaios aleatorizados, os grupos placebo, o preço, a indústria, a lentidão dos procedimentos; e era precisamente esse nível que a promessa do AZT, considerada em si mesma, deixava fora de foco. É esse domínio que Epstein (1996, p. 208-234) recompõe, justamente no ponto em que a temporalidade da ciência se choca com a temporalidade da morte. Estabelecer a eficácia de uma droga exige desenho experimental, recrutamento, definição de critérios e, sobretudo, tempo; para aqueles que sabiam estar vivendo com uma enfermidade então mortal, esse tempo estava longe de ser indiferente. Esperar podia significar morrer, e entrar em um estudo no qual se poderia receber placebo, em vez de tratamento, era experimentado como o risco de ser abandonado ao atraso.

Daí a consigna do ativismo — pôr os medicamentos nos corpos —, pela qual se reclamava acesso sem demora e se apontava a agência reguladora como um dos pontos de bloqueio que detinham os compostos (Epstein, 1996, p. 222). O movimento, contudo, não se opunha à ciência; o que colocava em questão era, antes, o seu ritmo, os seus critérios e as suas formas de acesso. Os grupos mais organizados não se limitavam a ensinar a desconfiar dos estudos, mas também a lê-los, submetendo sua credibilidade a exame como o fariam médicos e pesquisadores (Epstein, 1996, p. 233-234); e, ao se apropriarem da discussão sobre os dados estatísticos de sobrevida e sobre os mecanismos pelos quais o vírus adquire resistência, impunham aos próprios cientistas a exigência de tomar a sério os seus argumentos (Epstein, 1996, p. 231-232).

Essa apropriação se dava por meio de uma linguagem precisa: AZT ou zidovudina, ensaio clínico de fase II, placebo, critérios de entrada, dose, toxicidade, eventos clínicos, progressão para aids, sobrevida, tratamento precoce, contagem de linfócitos T-CD4+, antígeno p24, carga viral e mutações de resistência. Ao discutir se o AZT deveria ser indicado a pessoas assintomáticas com CD4 abaixo de 500/mm³, se o aumento de células T e a queda do p24 bastavam como sinais de eficácia, ou se a droga apenas adiava a progressão sem alterar a sobrevida, pacientes e ativistas deslocavam a controvérsia para dentro da própria racionalidade biomédica (EPSTEIN, 1996, p. 238-240).

O efeito, por sua vez, dá-se em duas direções. De um lado, pacientes e ativistas passam a manejar a linguagem da biomedicina, apropriando-se do vocabulário dos marcadores laboratoriais, dos desfechos clínicos, dos protocolos experimentais e da farmacologia antiviral. De outro, o AZT deixa de ser apenas objeto de prescrição médica para tornar-se objeto de controvérsia pública. Discutia-se não apenas se o medicamento funcionava, mas para quem deveria ser indicado, em que momento da infecção, com que grau aceitável de toxicidade, sob quais critérios de prova e com que direito de acesso antes do encerramento completo dos estudos. A disputa envolvia, assim, pacientes, ativistas, médicos, pesquisadores, indústria farmacêutica e agências reguladoras, deslocando o medicamento do espaço estritamente clínico para o campo ampliado da deliberação pública. Se antes se observava a molecularização da aids, agora se vê a politização do acesso ao molecular.

A inflexão decisiva deu-se em 1989. Um ensaio clínico de grande alcance passou a considerar o AZT sob outra perspectiva: o fármaco já não era avaliado somente em pessoas doentes, mas também em indivíduos infectados pelo HIV e ainda sem sintomas. Entre os que

receberam placebo, a probabilidade de avançar para manifestações de aids mostrou-se cerca de duas vezes maior do que entre os que fizeram uso da droga; por essa razão, o estudo foi interrompido antes do término previsto (Epstein, 1996, p. 238). Poucas semanas antes, outro ensaio já sugerira que o AZT atrasava a passagem de sinais leves para a forma manifesta da doença. Pela primeira vez, então, a concepção de combater o vírus era enunciada em relação a corpos nos quais a enfermidade permanecia sem expressão clínica.

Quando, em abril de 1990, os resultados completos do ACTG 019 foram publicados no *The New England Journal of Medicine*, o estudo passou a sustentar a indicação precoce da zidovudina para pessoas HIV positivas assintomáticas com CD4 abaixo de 500/mm³. Seus dados indicavam que o medicamento não impedia definitivamente a progressão para aids, mas parecia retardá-la no período observado, ao mesmo tempo que produzia aumento médio das células T e redução do antígeno p24. A publicação, contudo, não encerrava a controvérsia: permaneciam abertas as incertezas sobre segurança prolongada, resistência viral e impacto efetivo na sobrevida (EPSTEIN, 1996, p. 238-240). Um editorial resumia essa mudança já no título: tratava-se da hora do tratamento precoce. Mais importante, porém, era a fórmula por meio da qual essa mudança se deixava apreender: ao começar a terapia, uma pessoa de aparência saudável convertia-se em paciente, provavelmente ligada a um tratamento para toda a vida (Epstein, 1996, p. 240). A ação médica, em lugar de responder a uma doença já configurada, passava a constituir o paciente antes de qualquer imposição sintomática.

Pouco depois, ainda em 1990, a agência reguladora ampliou as indicações do medicamento para todas as pessoas infectadas cujo marcador imunológico estivesse abaixo de certo limite. Com isso, o conjunto dos destinatários do tratamento deixou de corresponder a cerca de cinquenta mil doentes e passou a abranger uma estimativa de seiscentas mil pessoas infectadas, mas sem doença manifesta (Epstein, 1996, p. 241). E a própria dirigente encarregada da área de antivirais na agência admitiu que a decisão concernia menos à ciência do que ao julgamento e à generalização (Epstein, 1996, p. 241). Torna-se visível, assim, a natureza da operação: não se dispunha de prova conclusiva; o que se afirmava era uma racionalidade de antecipação que o campo já não conseguia conter.

Sob o ângulo sociológico, esse episódio permite ver que a disponibilização de antirretrovirais a corpos nos quais a doença ainda não se tornara manifesta — corpos que, de acordo com certo parâmetro, ainda não "precisavam" do medicamento — não começou com a PrEP. Essa

dinâmica já se encontrava em operação aqui, quando se decidiu medicar o sujeito infectado, porém saudável, em nome de um porvir que se queria impedir. Trata-se, em suma, da mesma lógica: atuar no presente sobre uma doença que talvez nunca chegasse a se manifestar. A PrEP dará continuidade a esse movimento, ao levar o fármaco até mesmo àquele que nem sequer está infectado. Em síntese, antes da profilaxia, o dispositivo antirretroviral já passara a tomar o risco como se fosse doença.

Para a genealogia da PrEP, a dimensão temporal dessa inflexão é decisiva. O AZT já não é mobilizado apenas para tratar uma enfermidade instalada; ele passa também a funcionar como recurso para adiar um adoecimento ainda por vir. Intervém-se medicamente agora para deslocar para diante aquilo que ainda não se efetivou. Em junho de 1989, uma conferência internacional de grande relevo sobre aids já formulava esse horizonte, ao admitir que a infecção por HIV poderia tornar-se uma "doença crônica gerenciável" (*chronic manageable illness*) — sem cura, mas passível de manejo contínuo (Epstein, 1996, p. 238). Desde essa redefinição, o medicamento se inscreve em uma temporalidade voltada ao futuro: sua eficácia deixa de ser aferida somente pelo alívio de um sofrimento atual e passa a depender também da redução da probabilidade de um adoecimento posterior. É justamente nesse ponto que a perspectiva de Conrad acerca da medicalização se mostra especialmente elucidativa: a jurisdição médica começa a estender-se, saindo do corpo doente e alcançando o corpo biologicamente inscrito em uma trajetória de risco. No caso da aids, esse deslocamento precede a própria PrEP e vai do corpo em falência imunológica ao corpo infectado, assintomático e funcional, que passa então a ser constituído como objeto de uma intervenção antecipada. Se, com o tratamento precoce, a racionalidade antirretroviral se adianta à doença manifesta, com a PrEP esse movimento se intensifica, uma vez que a intervenção passa a incidir antes mesmo da infecção.

O AZT, por si só, já havia exposto as restrições de uma terapêutica pensada de modo isolado: o efeito favorável não durava, a toxicidade permanecia alta, e o vírus era capaz de desenvolver resistência. É nesse contexto que, entre o fim da década de 1980 e o início da de 1990, ganha força a aposta na terapia combinada. Tomada de esquemas já empregados contra outras enfermidades infecciosas, essa orientação buscava associar medicamentos para retardar a resistência viral e, talvez, reduzir a exposição do paciente às doses de maior toxicidade (Epstein, 1996, p. 265-269). Mais decisiva, contudo, do que a simples modificação do esquema terapêutico, foi a transformação do próprio modo de estabelecer se um

medicamento "funcionava". A eficácia, antes referida a desfechos tardios e extremos — a morte ou o aparecimento de infecções oportunistas no grupo de controle —, passa a ser disputada por meio de marcadores substitutivos: medidas indiretas, em especial a contagem de certas células de defesa, as CD4, e, depois, a quantidade de vírus circulante no sangue (Epstein, 1996, p. 269-273). Epstein indica que essa substituição esteve longe de reunir acordo: um indicador que antecipa o curso da doença não equivale, por si, à prova de que o tratamento traga benefício efetivo ao paciente; aquela contagem podia variar por razões distintas; e já havia exemplos de medicamentos que melhoravam indicadores tidos como seguros sem produzir ganho clínico real (Epstein, 1996, p. 270-273). É nesse domínio de incerteza que se constitui uma racionalidade de acompanhamento — a de seguir, medir e reajustar um corpo que ainda não adoeceu. É essa racionalidade que a próxima seção retoma sob outra chave, a da medicalização.

5.2. MEDICALIZAÇÃO

Peter Conrad oferece um ponto de partida decisivo para a discussão aqui aberta, porque torna possível abordar a medicalização não primariamente como censura moral à medicina, mas como instrumento analítico para apreender o modo pelo qual certos problemas vêm a ser inteligidos. Em seu sentido conceitual, medicalização não designa, de maneira necessária, uma "invasão" deliberada da medicina em esferas exteriores, nem implica conspiração, vontade unívoca ou expansão ilegítima por definição; o próprio autor assinala que se trata de um processo mais intrincado do que a mera incorporação de novos problemas pelos médicos, podendo nele intervir movimentos sociais, pacientes, consumidores, instituições e mercados (CONRAD, 2007, p. X). O núcleo da questão está na definição: um problema que antes não se formulava em linguagem médica passa a ser nomeado nesses termos, compreendido segundo um enquadramento médico e, eventualmente, objeto de intervenção médica (CONRAD, 2007, p. X). Essa chave, além disso, não se restringe a doenças já configuradas ou a condutas tomadas como desviantes, pois alcança também sujeitos que não estão doentes, mas que passam a ser classificados, monitorados e tratados em razão de sua exposição futura a certos eventos (CONRAD, 2007, p. X). É precisamente esse deslocamento, da doença para o risco, que orienta a análise subsequente da PrEP.

A medicalização do risco assinala um deslocamento conceitual bem determinado: elementos como a elevação da pressão arterial, o aumento do colesterol ou o excesso de peso deixam de valer somente como sinais probabilísticos de acontecimentos futuros e passam a ser

manejados como condições atuais, quase mórbidas — aquilo que Conrad, com apoio em Rosenberg, chama de protodisease (ch08). A diferença é decisiva, porque o risco não deixa de ser uma probabilidade estatística; o que ocorre, antes, é que ele fica recoberto por uma racionalidade clínica que o aborda como se já houvesse doença constituída.

É dessa operação que emerge uma figura particular, a do paciente parcial. Valendo-se de Greaves, Conrad caracteriza esse sujeito como alguém que não se percebe doente nem limitado, mas que, por apresentar certos traços passíveis de mensuração, é informado pela medicina de que se encontra sob risco de vir a desenvolver uma condição; e, por essa razão, torna-se alvo de vigilância e de intervenção clínicas (ch08). A inexistência de uma vivência subjetiva de adoecimento não interrompe a medicalização, porque o que passa a ser medicalizado é a própria situação de risco, sem dependência de sintomas.

Há aí, além disso, uma redefinição identitária mais ampla: indivíduos saudáveis são recompostos como sujeitos em risco. Conrad exemplifica essa transformação com o caso do tamoxifeno e do câncer de mama, em que a indústria farmacêutica, a comunidade médico-científica e as agências regulatórias convergiram para produzir tal reconfiguração (ch08). O horizonte argumentativo que daí se delineia é perturbador: à medida que se ampliam os incentivos para identificar e tratar riscos, as protodiseases tendem a se multiplicar e, no limite, todos podem converter-se em objetos da atenção médica — até que, nas palavras de Meador citadas por Conrad, desapareça o último indivíduo saudável (ch08).

Se o risco pode ser governado, no presente, como uma condição quase mórbida, permanece a questão que a etapa anterior apenas insinuava: por meio de que operação uma situação de risco passa a ser reconhecida como objeto clínico. Nesse ponto, o trabalho de Conrad, de 1976, torna-se particularmente esclarecedor, não tanto em razão de seu tema, a hiperatividade, mas pelo deslocamento analítico que introduz. Conrad não indaga se um comportamento "é", em si mesmo, uma doença; pergunta, antes, de que maneira ele chega a ser definido dessa forma. O desvio, em sua perspectiva, não constitui um atributo do indivíduo, do ato ou da circunstância, mas o efeito de um processo no qual determinadas condutas passam a ser nomeadas como desviantes, e determinados sujeitos, designados como tais (CONRAD, 2006, p. 1). O mesmo movimento incide sobre a própria ideia de doença: considerada sob esse prisma, ela deixa de aparecer como simples condição biológica e passa a ser entendida como resultado de um processo social, no qual intervêm a definição do desvio, uma linguagem classificatória e uma rede de interações (CONRAD, 2006, p. 4).

É desse deslocamento, precisamente, que Conrad retira sua formulação da medicalização do desvio: trata-se de definir um comportamento como problema médico e, de modo especial, de rotular certas condutas como doença. Uma vez produzida essa definição, cabe à medicina propor algum tratamento; e é aí que a definição se transforma em controle (CONRAD, 2006, p. 5). O que se altera historicamente, observa ele, não é a presença dessas condutas, mas a expansão do campo no qual a medicina atua como instância de controle social (CONRAD, 2006, p. 4). Definir, portanto, é também conferir jurisdição: ao converter uma conduta em problema médico, estabelece-se quem detém a competência para falar sobre ela e qual espécie de intervenção passa a ser considerada admissível.

Conrad não apresenta esse processo nem sob a figura de um progresso, nem sob a de um abuso; e é prudente acompanhá-lo nessa inflexão. Ele admite que há aquisições — redução da censura moral, atenuação do estigma —, mas assinala também um outro lado (CONRAD, 2006, p. 72). Entre as consequências, figura aquilo que denomina individualização dos problemas sociais: quando se diagnostica e se intervém sobre uma condição no indivíduo, passa-se a buscar no próprio sujeito tanto as causas quanto as respostas para problemas que poderiam ser compreendidos a partir da organização social (CONRAD, 2006, p. 74). Levado ao extremo, sugere, o ponto decisivo pode estar no controle social exercido pela medicina, na medida em que ela vem a ocupar, de fato, a posição de agente de conservação do status quo (CONRAD, 2006, p. 75). São observações formuladas com reserva, como desdobramentos possíveis, e não como sentença final.

Para o argumento que se desenvolve aqui, o rendimento desse percurso consiste menos em uma acusação do que em uma via de inteligibilidade: classificar uma exposição como risco é uma tradução, e não a leitura neutra de um dado. Não se quer dizer, com isso, que tal tradução seja ilegítima; quer-se apenas tornar perceptível que ela é uma tradução e que, por isso mesmo, envolve quem define, segundo quais critérios e em nome de quê.

A medicalização do risco, portanto, não pode ser entendida como um simples efeito interno da racionalidade preventiva, como se a presença de probabilidades epidemiológicas, por si só, fosse suficiente para transformá-las em matéria clínica. Tal processo supõe agentes que tenham condições de qualificar determinados estados como passíveis de tratamento e, ao mesmo tempo, de fazer circular a intervenção correspondente a essa qualificação. É aqui que o deslocamento assinalado por Conrad assume importância decisiva: os agentes da

medicalização não se reduzem mais à profissão médica, e o interesse — do mercado, da indústria — passa a participar tanto da definição do problema quanto da oferta da solução.

As três operações recompostas até aqui — o risco administrado sob a forma de um estado quase mórbido, a exposição elaborada como classificação e o interesse que sustenta ambas — encontram seu ponto de convergência num caso em que a doença, por definição, não se apresenta. Na PrEP, o que se medicaliza não é uma enfermidade já constituída, mas a possibilidade de uma infecção que talvez jamais venha a ocorrer. O medicamento não se dirige a sintoma, lesão ou diagnóstico; dirige-se a uma posição. Quem o utiliza é HIV-negativo e assim permanece enquanto o utiliza — e é precisamente essa condição, a de não estar doente, que o torna apto ao tratamento. O que se administra, sob medicação continuada, não é um corpo doente, mas um corpo exposto.

Tal deslocamento apenas se torna consistente porque a exposição, antes de tudo, foi transformada em critério de elegibilidade. Para que a profilaxia apareça como indicada, é necessário que um determinado conjunto de práticas e de circunstâncias seja interpretado sob a forma do risco e que esse risco — isto é, falando com precisão, uma probabilidade — passe a ser tratado, já no presente, como uma condição que exige condução clínica. A elegibilidade, portanto, não se limita a registrar uma realidade previamente inscrita no corpo de quem usa; ela introduz nesse corpo uma classificação produzida em outro lugar, segundo critérios fixados por instâncias determinadas e apoiada em interesses que vão além do cuidado individual. O risco de que a PrEP se ocupa não vem antes da medicina que o toma em carga; ambos se formam no mesmo movimento, aquele pelo qual se constitui como objeto clínico o que, fora dessa operação, permaneceria apenas como conduta, circunstância ou dado estatístico.

A parte do protocolo voltada ao adolescente permite perceber, com nitidez, uma operação que Conrad ajuda a formular: quando um problema é definido em chave médica, o que se faz não é apenas descrevê-lo de outro modo, mas também fixar uma jurisdição, estabelecer quem está autorizado a pronunciar-se sobre ele e delimitar quais intervenções passam a ser aceitáveis. Quando o documento dispõe que a pessoa com mais de quinze anos pode iniciar a profilaxia sem anuência de pais ou responsáveis, sob reserva de sigilo, exceto em situação de risco de vida, ele transfere o centro de autoridade do cuidado da família para a relação entre o adolescente e o profissional de saúde. Tal reconhecimento de autonomia não constitui, por si só, uma forma de captura; ele corresponde a um direito de acesso não submetido à tutela,

apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente e na obrigação de confidencialidade profissional. Convém, contudo, considerar o que isso ao mesmo tempo torna possível: a autonomia atribuída ao jovem é também, em certa medida, a autonomia de entrar por iniciativa própria no dispositivo que o define como sujeito de risco. O mesmo movimento que o libera da autorização parental o inscreve diretamente na relação clínica em que ele é produzido como alguém a ser acompanhado.

Permanece, além disso, aquilo que o acompanhamento previsto para o adolescente deixa entrever. O protocolo indica consultas em intervalos mais curtos, envio de lembretes por mensagem e teleatendimento, horários mais maleáveis, profissionais mais disponíveis e uma abordagem sem julgamento; e, juntamente com isso, prevê acesso a contracepção, saúde mental, manejo do uso de substâncias e apoio social. Trata-se de uma organização do cuidado atenta e, sob muitos aspectos, protetiva; reduzi-la simplesmente à vigilância empobreceria a questão. Mas ela também torna visível o movimento de individualização descrito por Conrad: a resposta a uma vulnerabilidade cuja origem é social se fixa no corpo do jovem e em sua adesão, enquanto uma infraestrutura inteira passa a funcionar para conservá-lo nesse regime, ao mesmo tempo que a entrada pela PrEP franqueia um acesso ao monitoramento mais amplo de sua vida. Reconhecer isso não significa rejeitar a oferta, que o protege de um risco efetivo; significa, isto sim, explicitar que, antes de operar como técnica de prevenção, a PrEP pressupõe — também, e talvez sobretudo, no caso do adolescente — um sujeito que precisou ser constituído como tal.

5.3. BIOCIDADANIA

O percurso por Conrad estabeleceu o que a medicalização faz: como certos estados passam a ser definidos em termos médicos e como, ao defini-los, se atribui jurisdição. Resta, porém, uma pergunta que esse mapeamento não responde e que organiza a passagem para Rose — a de saber quem o indivíduo se torna ao ser inserido nesse regime. Rose toma o diagnóstico da medicalização como ponto de partida, mas desloca-lhe o foco: identificar a ampliação do campo médico não diz nada, ainda, sobre as formas de subjetividade que essa ampliação produz. O próprio Rose nota que a extensão da autoridade médica — da dietética ao autodiagnóstico, do consumo de suplementos ao tratamento doméstico — foi, ao mesmo tempo, contestada por movimentos que recusavam o poder paternalista dos médicos sobre seus pacientes (Rose, 2007). É esse duplo movimento que exige um segundo passo analítico: examinar os modos pelos quais os indivíduos passam a relacionar-se consigo mesmos como

criaturas biológicas e a reconhecer no corpo o território privilegiado de governo e de intervenção. É desse sujeito — e não mais da jurisdição que o enquadra — que tratam os conceitos a seguir.

A molecularização já compareceu na análise do AZT: vimos como a vida, compreendida no nível de seus mecanismos isoláveis e recombináveis, se oferece à intervenção, ao cálculo e à política. Convém agora articulá-la ao conceito que lhe dá alcance propriamente político — o de política vital. Diferentemente das políticas de saúde dos séculos XVIII e XIX, voltadas às taxas de natalidade, mortalidade e epidemias, e diferentemente também da gestão da qualidade populacional que marcou a primeira metade do século XX, a política da vida contemporânea já não se delimita pelos polos da doença e da saúde: volta-se para o controle, a gestão, a remodelação e a modulação das próprias capacidades vitais dos seres humanos enquanto criaturas vivas (Rose, 2007). O deslocamento é, antes de tudo, de objeto — de uma política que incide sobre corpos e populações para uma que opera sobre a vida em si, no plano molecular. É sobre esse terreno, em que intervir no vital deixa de supor a presença de uma doença, que a individualidade somática passa a ser governada — e que uma profilaxia destinada a quem não está doente encontra sua condição de inteligibilidade.

Sob esse regime molecular, emerge um sujeito convocado a calcular o próprio risco e a gerir ativamente seu futuro biológico. Pacientes são crescentemente instados a se tornarem consumidores ativos e responsáveis de serviços e produtos médicos, de farmacêuticos a testes genéticos e tecnologias reprodutivas (Rose, 1992, 1999 apud Rose, 2007). O vocabulário do risco genético oferece uma grade de percepção que informa decisões sobre como conduzir a vida, ter filhos, contrair matrimônio ou planejar uma carreira; a isso Rose associa o conceito de *prudência genética* — uma norma que obriga o indivíduo a gerir o presente à luz do conhecimento de seu próprio futuro biológico, introduzindo novas distinções entre sujeitos responsáveis e irresponsáveis (Rose, 2007). Esse processo, porém, não se resolve em pura sujeição nem em pura autonomia: o mesmo indivíduo que, mesmo sendo saudável, se vê obrigado a conduzir a vida sob a sombra da autoridade médica para ser considerado responsável, encontra nessa responsabilização a linguagem de sua própria liberdade, autorrealização e prudência (Rose, 2007). A tensão entre esses dois polos — obrigação e agência — é constitutiva, não acidental.

CONCLUSÃO

Este trabalho partiu de uma pergunta deliberadamente formulada em termos de condições de possibilidade: o que torna possível, no Brasil, a expansão do acesso à PrEP a adolescentes de 15 a 19 anos? Ao final do percurso, a resposta que se deixa enunciar não tem a forma de uma causa, mas a de um terreno. A extensão da profilaxia ao jovem, codificada no PCDT de 2025, não se explica apenas pela urgência epidemiológica que o próprio documento invoca; ela se tornou possível porque já estavam dispostos, quando o protocolo a enunciou, os elementos que a sustentam: um dispositivo da aids montado ao longo de quatro décadas, no qual medo público, saber biomédico, ativismo, gestão por projetos e direito à saúde se articularam; uma racionalidade antirretroviral que, desde o AZT e o tratamento precoce, aprendera a medicar corpos sem doença em nome de um porvir a impedir; uma categoria de adolescência historicamente produzida e disponível para ser operacionalizada por marcadores etários, comportamentais e jurídicos; e uma forma documental, a do protocolo clínico, capaz de condensar mandato, evidência e fluxo administrativo numa só peça normativa. O que a análise mostrou, ao percorrer esses planos, é que o PCDT não encontra o adolescente que protege: ele o constitui, sexualmente ativo, autônomo, compreendente e acompanhado, no gesto mesmo da proteção. Não decorre daí denúncia alguma, e o trabalho insistiu nessa advertência do início ao fim; decorre, antes, um deslocamento da pergunta, que deixa de opor cuidado e controle para descrever o movimento em que ambos se produzem juntos.

O percurso que sustenta essa resposta pode ser retomado em seus movimentos principais. O primeiro capítulo recusou definir o dispositivo antes de o pôr a funcionar: deixou que o conceito operasse sobre o protocolo e, ao fazê-lo, mostrou que o dado epidemiológico não se limita a reconhecer um grupo de risco, mas produz o jovem como superfície de incidência; que a dispensa da autorização parental desativa o ponto de passagem pelo qual a sexualidade do menor transitava pela família, religando-a à relação clínica; que o sigilo opera como condição de entrada, e a autonomia como efeito, inseparável de um acompanhamento que prossegue. A genealogia do dispositivo da aids situou essa operação numa história: nos anos 1980, o medo público, a cobertura televisiva e a fala autorizada do especialista compuseram o quadro em que a doença se tornou reconhecível no país, ao mesmo tempo em que o movimento sanitário, as primeiras organizações e a gramática do direito à saúde davam à epidemia outro destino político; nos anos 1990, essa rede converteu-se em governamentalidade, com programas, editais, financiamento internacional e a formação de um sujeito preventivo convocado a governar a si mesmo. A reconstituição da adolescência mostrou, por sua vez, que a categoria sobre a qual o protocolo incide é ela própria uma

produção histórica, e que a figura homogênea do adolescente apto à norma desde os quinze anos pressupõe aquele grupo constituído que Bourdieu identifica como ficção, apagando a distância entre juventudes que não se equivalem. A leitura do PCDT como dispositivo documental, apoiada em Prior, fez ver a autoria distribuída, o mandato estatal e a cadeia decisória que o texto condensa, e que o autorizam a circular como protocolo oficial. A genealogia do medicamento, enfim, indicou que medicar corpos sem doença não começou com a PrEP: do AZT ao tratamento precoce, a racionalidade antirretroviral já se adiantava à doença manifesta, constituindo o paciente parcial de que fala Conrad e inscrevendo a vida, na chave de Rose, numa política e numa economia do vital.

O corpo — inclusive o corpo assintomático referido antes — passa a ser seguido por sinais laboratoriais, e o tratamento deixa de se apresentar como intervenção pontual para tornar-se uma prática contínua de medir, interpretar e reajustar, atenta às combinações, à toxicidade, à resistência e à adesão. A aids começa, então, a se distanciar da oposição imediata entre vida e morte e a se aproximar de uma administração por indicadores — ainda como horizonte instável, e não como forma já consolidada.

Há, contudo, uma outra dimensão que essa genealogia faz aparecer e que a linguagem da molecularização torna nomeável: a inscrição da vida no interior de uma economia. Como assinala Rose, desde o momento em que a vida é analisada em componentes discretos — sequências, moléculas, suscetibilidades —, a vitalidade mesma pode ser separada, acionada e inserida em novas articulações econômicas, de tal sorte que biomedicina e mercado já não se apresentam como esferas exteriores entre si (Rose, 2007). No caso do AZT, isso já se deixava perceber — no custo, na indústria, na disputa pelo acesso —; com a profilaxia, porém, essa forma ganha acabamento: o PCDT não se limitará a oferecer uma técnica preventiva, mas ordenará o ponto em que um corpo definido como exposto passa a figurar como destinatário de um fármaco de uso continuado, cuja efetividade depende precisamente da permanência do usuário no regime. A condição que se conserva — o estatuto de soronegativo — constitui, nesse sentido, também um valor que deve ser mantido ao longo do tempo; e a população elegível, por sua vez, configura um público cuja vitalidade sustenta um circuito em que se articulam saúde pública, indústria e administração do risco.

Se, nas formulações mais clássicas, a profissão médica figurava como instância principal da medicalização, nas configurações contemporâneas esse lugar se redistribui em direção ao mercado, aos consumidores e às empresas biomédicas, modificando não apenas os agentes da

medicalização, mas ainda os próprios objetos que podem ser medicalizados e as finalidades em função das quais isso se realiza (CONRAD, 2007, p. X).

Nesse quadro, a indústria farmacêutica não apenas atende a demandas clínicas já dadas; ela intervém de modo ativo na produção dos riscos como alvos terapêuticos, fazendo avançar, ao mesmo tempo, a definição inteligível do problema e a oferta da solução. Por isso, antes de considerar a PrEP como técnica de prevenção, é necessário reconhecer que o seu funcionamento depende de uma operação prévia: a constituição de um sujeito de risco, sem a qual o medicamento não ganha nem pertinência clínica nem projeção mercadológica.

Se a doença comparece como resultado de uma definição, então "estar exposto" tampouco constitui uma apreensão neutra do real: trata-se de uma classificação produzida, apoiada em critérios e em agentes que a instituem. No caso da PrEP, a elegibilidade se apoia precisamente nessa operação — a de classificar determinados comportamentos como arriscados —, de tal sorte que a exposição ao HIV se converte em objeto clínico antes mesmo de haver, e sem que seja necessário haver, doença constituída. O processo de individualização descrito por Conrad oferece, nesse ponto, um paralelo nítido: a resposta ao risco se inscreve no corpo de cada um, sob medicação contínua, ao passo que as condições sociais que produzem essa exposição permanecem em plano secundário.

A indicação da profilaxia ao adolescente fica subordinada a que ele compreenda a estratégia e o respectivo acompanhamento e, no caso da modalidade sob demanda, a que se possa verificar sua capacidade de entender o esquema de doses. Lido a partir de Conrad, tal critério não opera somente como cautela clínica; ele institui que o acesso ao medicamento depende de uma aptidão aferida para administrar o próprio risco. Antes de receber o comprimido, o jovem deve mostrar que entende a posição em que foi situado e que pode conduzi-la com a regularidade que ela requer. O paciente parcial, aqui, não é apenas aquele que recebe medicação em razão daquilo a que se expõe; é também aquele de quem se exige, como condição de entrada, a competência para conduzir-se como gestor de uma probabilidade. A profilaxia supõe, portanto, não somente um corpo exposto, mas um sujeito disposto a reconhecer-se como tal e a ordenar sua conduta em função disso — disposição que, no adolescente, se constitui juntamente com a própria trajetória.

O usuário da PrEP não se encontra doente, não está incapacitado, não apresenta sintomas e, ainda assim, faz uso diário de medicamento, submete-se a exames regulares e continua sob

acompanhamento — não em razão de algo que possua, mas em razão daquilo a que se acha exposto. Trata-se, em sentido rigoroso, do paciente parcial: alguém para quem a saúde, em vez de afastar a medicina, converteu-se precisamente no motivo de nela ingressar. Assinalar essa operação não significa rejeitá-la; significa, antes, perceber que, antes mesmo de operar como técnica preventiva, a PrEP pressupõe um sujeito que teve de ser constituído como sujeito de risco. São as condições dessa constituição, bem como os seus efeitos, que importa continuar a interrogar.

Atravessados esses planos, um mesmo achado se repete e ganha consistência. Em cada um deles, a operação observada foi a de proteger e produzir num único gesto. A epidemiologia, ao justificar a ampliação, constitui o jovem como superfície legível de incidência; o direito, longe de comparecer como limite a transpor, é mobilizado como tática, e o próprio Estatuto que emancipa o adolescente do pátrio poder autoriza sua inscrição na relação clínica; o sigilo, que numa representação jurídica do poder seria supressão, funciona aqui como condição de entrada, mecanismo e não brecha; a autonomia, enfim, não é encontrada e respeitada, mas produzida na exigência de que o adolescente compreenda a profilaxia e o acompanhamento que a acompanha, de modo que a condição de sua liberdade é o ingresso num monitoramento que prossegue. A esse desenho soma-se o que Conrad permite nomear: a resposta a uma vulnerabilidade cuja origem é social se fixa no corpo do jovem e em sua adesão, enquanto as condições que produzem a exposição permanecem em plano secundário, convertidas em variáveis de uma grade que as torna governáveis. E soma-se, com Rose, o horizonte em que esse mesmo sujeito pode exceder a posição de paciente que adere: a cidadania biológica lembra que o acesso ao fármaco também pode ser reivindicado como direito, contestado, organizado coletivamente, e que o adolescente convocado como gestor do próprio risco não está, por isso, condenado a ser apenas isso. É essa duplicidade que dissolve a alternativa entre cuidado e controle: reconhecer a importância pública do protocolo e descrever os seus efeitos de subjetivação não constituem teses rivais: trata-se do mesmo objeto apreendido em duas escalas.

Cabe, por fim, registrar os limites desta análise e o que ela deixa aberto. O trabalho se deteve, por escolha de método, no plano da página: leu o protocolo como dispositivo escrito, e suas conclusões valem para os efeitos de subjetivação inscritos no documento, não para os seus usos. Como o próprio Prior adverte, o texto é apenas uma das dimensões da vida social de um documento; saber como o PCDT funciona nos serviços, nas dispensações, nos encontros entre

adolescentes e profissionais, exigiria outra estratégia de pesquisa, de corte empírico, que este estudo não realizou e que se apresenta como seu desdobramento natural. Duas questões, em particular, ficam indicadas para esse trabalho futuro. A primeira é a das juventudes no plural: se a figura homogênea do adolescente elegível pressupõe um grupo constituído que a sociologia ensina a tratar como ficção, resta investigar quem efetivamente acessa a profilaxia, sob quais condições e com quais trajetórias, isto é, como a desigualdade que o documento converte em variável retorna na implementação. A segunda diz respeito à rede de evidências em que o protocolo se apoia, cujo cânone de ensaios, centrado no masculino, já se deixa ver na restrição da modalidade sob demanda a certos corpos; acompanhar como essa herança se reproduz ou se corrige nas próximas revisões do documento é tarefa que ultrapassa este texto. O que o trabalho oferece, ao final, não é um veredito sobre a medida, mas uma descrição do terreno que a tornou possível e das figuras que ela faz existir; e a pergunta com que se encerra é a mesma que o deslocou desde o início: não se o adolescente é livre ou governado, mas por meio de quais procedimentos ele se tornou, ao mesmo tempo, uma coisa e outra.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **Consulta à situação de documentos**. Brasília, DF: Anvisa, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/consulta-a-situacao-de-documentos>. Acesso em: 15 jun. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 204, de 27 de dezembro de 2017**. Dispõe sobre o enquadramento na categoria prioritária de petições de registro, pós-registro e anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos. Brasília, DF: Anvisa, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2017/rdc0204_27_12_2017.pdf. Acesso em: 15 jun. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 1.001, de 11 de dezembro de 2025**. Dispõe sobre critérios de priorização de análise de petições de registro e pós-registro de medicamentos. Brasília, DF: Anvisa, 2025. Disponível em: <https://anvisaegis.datalegis.net>. Acesso em: 18 jun. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **TRUVADA® (entricitabina + fumarato de tenofovir desoproxila): nova indicação**. Brasília, DF: Anvisa, 12 abr. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/truvada-r-entricitabina-fumarato-de-tenofovir-desoproxila-nova-indicacao>. Acesso em: 15 jun. 2026.

ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. Tradução de Dora Flaksman. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

BARATA, Germana Fernandes. **A primeira década da AIDS no Brasil: o Fantástico apresenta a doença ao público (1983-1992)**. 2006. Dissertação (Mestrado em História Social) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-07072006-124258/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BOAS, Franz. **The mind of primitive man**. Revised edition. New York: The Macmillan Company, 1938.

BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In: BOURDIEU, Pierre. **Questões de sociologia**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p. 112-121.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **Os herdeiros: os estudantes e a cultura**. Tradução de Ione Ribeiro Valle e Nilton Valle. Florianópolis: Editora da UFSC, 2014.

BRASIL. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde — SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Consulta Pública Conitec/SECTICS nº 53/2024: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-conitec-sectics-n-53-2024-prep>.

Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

Disponível

em:

<https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-pre-exposicao-prep-oral-a-infeccao-pelo-hiv.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. **Relatório de Recomendação nº 739: Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em:

https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/20220830_relatorio_739_pcdt_prep.pdf. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. **Portaria SCTIE/MS nº 90, de 25 de agosto de 2022**. Torna pública a decisão de atualizar, no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2022/prt0090_30_08_2022.html. Acesso em: 15 jun. 2026.

CONRAD, Peter. **Identifying hyperactive children: the medicalization of deviant behavior**. Expanded edition. Aldershot: Ashgate, 2006.

CONRAD, Peter. **The medicalization of society: on the transformation of human conditions into treatable disorders**. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007.

DE LA DEHESA, Rafael. NGOs, governmentality, and the Brazilian response to AIDS: a multistranded genealogy of the current crisis. **Feminist Studies**, College Park, v. 43, n. 2, p. 262-290, 2017. DOI: <https://doi.org/10.15767/feministstudies.43.2.0262>.

DURKHEIM, Émile. **L'évolution pédagogique en France**. Paris: Félix Alcan, 1938.

EPSTEIN, Steven. **Impure science: AIDS, activism, and the politics of knowledge**. Berkeley: University of California Press, 1996.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1998.

FOUCAULT, Michel. **Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979)**. Edição estabelecida por Michel Senellart sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana. Tradução de Eduardo Brandão. Revisão da tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2008b.

FOUCAULT, Michel. **Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978)**. Edição estabelecida por Michel Senellart sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana. Tradução de Eduardo Brandão. Revisão da tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2008a.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1987.

HALL, G. Stanley. **Adolescence: its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education**. New York: D. Appleton and Company, 1904. v. 1.

HERZLICH, Claudine; PIERRET, Janine. Uma doença no espaço público: a AIDS em seis jornais franceses. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, supl., p. 71-101, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312005000300005>.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital**. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

MAZON, Marcia da Silva. Dos diagnósticos aos manuais: mercado farmacêutico e transtornos mentais da infância em questão. **Política & Sociedade**, Florianópolis, v. 19, n. 46, p. 115-140, set./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2020.e75323>.

MAZON, Marcia da Silva. Saúde mental infantil e o TDAH como expressão de embates no setor. **Caderno CRH**, Salvador, v. 37, p. 1-15, e024045, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v37i0.62481>.

MAZON, Marcia da Silva; CAPONI, Sandra. Disseminação dos saberes expertos no domínio da infância. **Estudos de Sociologia**, Araraquara, v. 27, n. esp. 2, e022035, 2022. DOI: <https://doi.org/10.52780/res.v27iesp.2.17572>.

MAZON, Marcia da Silva; THOLL, James. Entre o uso racional e a magia: consumo do metilfenidato, TDAH e escolas. **Política & Sociedade**, Florianópolis, v. 21, n. 51, p. 47-69, maio/ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2022.e91454>.

MEAD, Margaret. **Coming of age in Samoa: a psychological study of primitive youth for Western civilisation**. New York: William Morrow & Company, 1928.

PELÚCIO, Larissa; MISKOLCI, Richard. A prevenção do desvio: o dispositivo da aids e a repatologização das sexualidades dissidentes. **Sexualidad, Salud y Sociedad: Revista Latinoamericana**, Rio de Janeiro, n. 1, p. 125-157, 2009. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/SexualidadSaludySociedad/article/view/29>. Acesso em: 15 jun. 2026.

PERLONGHER, Néstor. **O que é AIDS**. São Paulo: Brasiliense, 1987.

PRIOR, Lindsay. **Using documents in social research**. London: Sage Publications, 2003.

ROSE, Nikolas. **Governing the soul: the shaping of the private self**. 2. ed. London: Free Association Books, 1999.

ROSE, Nikolas. **The politics of life itself: biomedicine, power, and subjectivity in the twenty-first century**. Princeton: Princeton University Press, 2007.

SILVA, Marcos Gleison Araujo; MONTEIRO, Simone. Juventude e aids: testagem e gestão de risco entre homens autodeclarados gays ou bissexuais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, e360112, 2026. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/physis/2026.v36n1/e360112/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

STIEGLER, Bernard. **Taking care of youth and the generations**. Translated by Stephen Barker. Stanford: Stanford University Press, 2010.

WEBER, Max. Classe, estamento, partido. In: GERTH, H. H.; MILLS, C. Wright (org.).